

医的な引受目安のガイドライン

本ガイドラインには、生命保険申込者の病気、ケガ、健康状態や検査異常（以下総称して「傷病」といいます）を評価して、その契約の引受可否を決定（医務査定）する際の目安を掲載しています。弊社の医務査定基準書では、傷病に対する評価が年齢・性別・重症度・手術や入院の有無等により細分化して規定されているものが多く、そのすべてを本ガイドラインに要約することは困難です。そのため、本ガイドラインでは、弊社の医務査定基準書に記載されている傷病の中で、実務上多く見られる、代表的なものを取り上げて、一部簡略化して記載しています。

【使用上のご注意】

- ① 本ガイドラインは、引受の目安であり、査定結果をお約束するものではありませんので、あくまでも参考資料としてご利用ください。正式な査定結果が必要な場合には、必ず医務事前査定をお願いします。
- ② 単一の傷病時の目安であり、複数の傷病がある場合には結果が異なることがあります。
- ③ 現在入院中や寝たきり状態の場合、または今後入院や手術の予定がある場合はお引受ができません。
- ④ 過去に一度でもがん（上皮内がん・肉腫・血液のがんを含む）の罹患歴のある方は、ガン関連保障には加入できません。
- ⑤ 診査または告知書で引受可否の判断が出来ない場合、追加診査を依頼、もしくは、健診結果や診断書の提出をお願いすることがあります。
- ⑥ 「要診査」となっている場合、今回のお申込がガン保障のみであれば診査は不要です。また、死亡保障・医療保障・特定疾病保障についても、金額・日額等によっては不要となる場合があります。
- ⑦ 医療保障の不担保期間は、可能性が高い不担保年数を記載しています。告知内容等によって結果が異なる場合があります。
- ⑧ こだわり変額保険、未来につなげる終身保険は、「死亡」欄をご確認ください。ただし、左記の商品は、商品特性上、「割増」の場合は「×」になる可能性がありますのでご注意ください。
- ⑨ 本ガイドラインは、発行時点における医務査定基準書に基づいて作成されています。医務査定基準書は随時見直しを行う予定ですので、査定結果には差異が生ずる可能性があることにご留意願います。

2024年9月

マニユライフ生命保険株式会社

【対象とする保障内容】

死亡：こだわり終身保険v2、こだわり外貨終身、こだわり収入保障、こだわり変額保険、未来につなげる終身保険等の死亡保障保険・特約、こだわり医療保険 with PRIDEに付加される終身保険特約

医療：総合医療保障特約(マニフレックス・マニメッド用)、こだわり医療保険 with PRIDE

※ 総合医療保障特約(マニフレックス・マニメッド用)、こだわり医療保険 with PRIDEに付加される各種特約(七大生活習慣病入院特約、七大生活習慣病無制限特約、継続年金三大疾病保障特約、三大疾病保険料払込免除特約、女性疾病入院特約・先進医療特約・メンタル疾患延長特約・在宅治療特約・生存給付特約・終身保険特約)は、医療評価が○であっても付加できない場合があります。

ガン：こだわりガン保険、ガン治療保険、手術給付金付ガン入院特約等のガン保障保険・特約

※ 過去に一度でもがん(上皮内がん・肉腫・血液のがんを含む)の罹患歴のある方は、ガン関連保障には加入できません。

特定疾病：特定疾病保険料払込免除特約・特約(こだわり終身保険v2・こだわり外貨終身・こだわり収入保障保険用)、三大疾病保険料払込免除特約(こだわり医療保険 with PRIDE)、特定疾病保障特約

【用語の定義】

現症：現在病気がまだ治っていない状態

治療中：医師の指導・管理下で、食事療法・内服療法・注射療法・吸入療法・外科的療法等を行っている状態

発症後：病気の症状が現れた後

寛解後：症状が落ち着いて安定した後

治癒後：疾患が全治し、かつ治療を終了した後

既往症：現在は治癒しているが、以前にかかったことのある病気

×：お引受できない場合

○：お引受できる場合

割増：特別保険料の領収により、お引受できることがある場合

削減：保険金削減法により、お引受できることがある場合

特障：視力障害についての特定障害状態不担保を条件に、お引受できることがある場合

不担保：特定部位・指定疾病についての不担保を条件に、お引受できることがある場合
(不担保番号に対応する身体部位・指定疾病の内容は下表のとおりです)

女疾：×：女性疾病入院特約がお引受できない場合

【その他】

・目安に幅がある場合、左側の評価となる可能性が高くなります。(例：“割増～○”⇒この場合は割増となる可能性がより高い)

・補足欄に「個別判断」と記載がある場合は、医務事前査定などをご活用下さい。

身体部位・指定疾病の番号と名称	
1. 眼球、眼球付属器および視神経	28. 左股関節部
2. 耳(内耳、中耳、外耳を含みます。)および乳様突起	29. 右股関節部
3. 鼻(鼻腔、副鼻腔および外鼻を含みます。)	30. 左上肢(左肩関節部を除きます。)
4. 口腔(口唇および口蓋を含みます。)、歯、舌、顎下腺、耳下腺および舌下腺	31. 右上肢(右肩関節部を除きます。)
5. 甲状腺	32. 左下肢(左股関節部を除きます。)
6. 咽頭および喉頭	33. 右下肢(右股関節部を除きます。)
7. 気管、気管支、肺、胸膜および胸郭	34. 子宮体部(帝王切開を受けた場合に限り。)
8. 胃および十二指腸(当該部位の手術に伴い空腸の手術を受けた場合は、空腸を含みます。)	35. 鼠蹊部(鼠蹊ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に限り。)
9. 盲腸(虫垂を含みます。)および回腸	36. 外傷または手術を受けた部位(会社が指定した外傷または手術の後遺症に限り。)
10. 大腸	37. 身体表層の腫瘍、ケロイドまたは母斑(あざ)がある部位(会社が指定した腫瘍、ケロイドまたは母斑に限り。)
11. 直腸および肛門	38. 食道および横隔膜
12. 腹膜(腹腔内臓器の癒着を生じた場合を含みます。)	39. 皮膚
13. 肝臓、胆嚢および胆管	40. 皮膚炎・湿疹(アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎を含みます)
14. 脾臓	41. 骨折等の内固定具抜去
15. 腎臓および尿管	42. 白内障
16. 膀胱および尿道	43. 緑内障
17. 睪丸および副睪丸	44. 副鼻腔炎・蓄膿症
18. 前立腺	45. 扁桃腺炎・扁桃周囲膿瘍・扁桃肥大
19. 乳房(乳腺を含みます。)	46. 気胸
20. 子宮(妊娠または分娩に異常が生じた場合を含みます。)	47. 異常妊娠・異常分娩(帝王切開を含みます。)
21. 卵巣、卵管および子宮付属器	48. 子宮筋腫
22. 頸椎部(当該神経を含みます。)	49. 子宮内膜症
23. 胸椎部(当該神経を含みます。)	50. 胆石・胆嚢炎
24. 腰椎部(当該神経を含みます。)	51. 腎・尿路結石
25. 仙骨部および尾骨部(当該神経を含みます。)	52. 痔瘻・痔核・脱肛・肛門周囲膿瘍
26. 左肩関節部	
27. 右肩関節部	

【目次】

分類	ページ
体格	18
血圧値	19-20
循環器	21-24
尿糖・糖尿病	25
内分泌と代謝異常	26-27
脳血管疾患	28
神経系	29-30
感覚器 眼	31-34
感覚器 耳鼻科	35-37
消化器	38-44
呼吸器	45-47
泌尿器	48-52
精神疾患	53-54
新生物	55-59
血液・造血器	60-61
感染症	62
妊娠・分娩	63-64
婦人科	65-68
皮膚	69-70
骨の疾患	71-72
膠原病と筋の異常	73
外傷	74-77
健康診断書・人間ドックにおける経過観察判定についての目安	78-79

		疾傷名	かな	ページ
あ行	あ	RSR' パターン	あーるえすあーるぱたーん	<u>78</u>
		R 波高電位	あーるはこうでんい	<u>78</u>
		IgA 血管炎	あいじーえーけっかんえん	<u>61</u>
		IgA 腎症	あいじーえーじんしょう	<u>48</u>
		ITP(特発性血小板減少性紫斑病)	あいていーぴー(とくはつせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう)	<u>61</u>
		アキレス腱断裂	あきれすけんだんれつ	<u>77</u>
		悪性睾丸腫瘍	あくせいこうがんしゅよう	<u>58</u>
		悪性黒色腫(メラノーマ)	あくせいこくしよくしゅ(めらの一ま)	<u>58</u>
		悪性貧血(巨赤芽球性貧血)	あくせいひんけつ(きよせきがきゅうせいひんけつ)	<u>60</u>
		悪性リンパ腫	あくせいりんぱしゅ	<u>58</u>
		アジソン病	あじそんびょう	<u>26</u>
		アトピー性皮膚炎	あとぴーせいひふえん	<u>69</u>
		アルコール依存症	あるこーるいぞんしょう	<u>54</u>
		アルコール性肝炎	あるこーるせいかんえん	<u>42</u>
		アルコール中毒(慢性)	あるこーるちゅうどく(まんせい)	<u>54</u>
		アルツハイマー病	あるつはいまーびょう	<u>29</u>
		アレルギー性紫斑病	あれるぎーせいしはんびょう	<u>61</u>
		アレルギー性鼻炎	あれるぎーせいびえん	<u>35</u>
	い	EBウイルス肝炎	いーびーういるすかんえん	<u>41</u>
		胃炎	いえん	<u>38</u>
		胃炎(慢性)	いえん(まんせい)	<u>38</u>
		胃潰瘍	いかいよう	<u>39</u>
		胃潰瘍瘢痕	いかいようはんこん	<u>79</u>
		胃下垂	いかすい	<u>79</u>
		胃癌	いがん	<u>58</u>
		胃憩室	いけいしつ	<u>79</u>
		胃酸過多症	いさんかたしょう	<u>38</u>
		胃食道逆流症	いしょくどうぎゃくりゅうしょう	<u>38</u>
		異所性腎	いしょせいじん	<u>52</u>
		I 型糖尿病	いちがたとうによびょう	<u>25</u>
		1度房室ブロック	いちどぼうしつぶろく	<u>78</u>
		胃腸炎(急性)	いちょうえん(きゅうせい)	<u>38</u>
		一過性脳虚血発作(TIA)	いっかせいのうきょけつほっさ(TIA)	<u>28</u>
		胃粘膜下腫瘍	いねんまくかしゅよう	<u>79</u>
		胃びらん	いびらん	<u>79</u>
		胃部 X 線所見(健康診断)	いぶえつくすせんしよけん(けんこうしんだん)	<u>79</u>
		いぼ痔	いぼじ	<u>40</u>
		胃ポリープ	いぼりーぷ	<u>55、79</u>
		イレウス(腸閉塞)	いれうす(ちょうへいそく)	<u>38</u>
		陰茎癌	いんけいがん	<u>58</u>
		咽頭癌	いんとうがん	<u>58</u>
		陰嚢水腫	いんのうすいしゅ	<u>51</u>
		インフルエンザ	いんふるえんざ	<u>62</u>
	う	ウェゲナー肉芽腫	うえげなーにくがしゅ	<u>73</u>
		右軸偏位	うじくへんい	<u>78</u>
		うつ病	うつびょう	<u>53</u>
	え	HIV(後天性免疫不全症候群)	えいちあいびい(こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん)	<u>61</u>
		Hb(ヘモグロビン)	えいちびー(へもぐろびん)	<u>60</u>
		ASD(心房中隔欠損症)	えーえすでいー(しんぼうちゅうかくけっそんしょう)	<u>21</u>

		疾傷名	かな	ページ
あ行 (続)	え	ALS(筋萎縮性側索硬化症)	えーえるえす(きんいしゆくせいそくさくこうかしょう)	<u>30</u>
		A型肝炎(急性)	えーがたかんえん(きゅうせい)	<u>41</u>
		ADHD(注意欠陥・多動性障害)	えーでいーえいちでいー(ちゅういけっかん・たどうせいしょうがい)	<u>54</u>
		SLE(全身性エリテマトーデス)	えすえるいー(ぜんしんせいえりてまとーです)	<u>73</u>
		S 状結腸癌	えすじょうけつちょうがん	<u>58</u>
		エコノミークラス症候群(深部静脈血栓症)	えこのみーくらすじょうこうぐん(しんぶじょうみやくけっせんしょう)	<u>22</u>
		円錐角膜	えんすいかくまく	<u>33</u>
	お	横隔膜の挙上	おうかくまくのきょじょう	<u>78</u>
		黄斑上膜	おうはんじょうまく	<u>33</u>
		黄斑前膜	おうはんぜんまく	<u>33</u>
		黄斑変性症	おうはんへんせいしょう	<u>33</u>
		おたふく風邪	おたふくかぜ	<u>62</u>
		親知らず	おやしらず	<u>37</u>
か行	か	外耳炎	がいじえん	<u>36</u>
		外痔核	がいじかく	<u>40</u>
		外傷性くも膜下出血	がいしょうせいくもまくかしゅつけつ	<u>74</u>
		潰瘍性大腸炎	かいようせいだいちょうえん	<u>39</u>
		解離性大動脈瘤	かいりせいだいどうみゃくりゅう	<u>21</u>
		過活動膀胱	かかつどうぼうこう	<u>50</u>
		顎関節症	がくかんせつしょう	<u>72</u>
		拡張型心筋症	かくちょうがたしんきんしょう	<u>22</u>
		角膜炎	かくまくえん	<u>32</u>
		角膜潰瘍	かくまくかいよう	<u>32</u>
		下肢の骨折(大腿骨、膝関節部、大腿骨頸部および股関節以外)	かしのこっせつ(だいたいこつ、ひざかんせつぶ、だいたいこつけいぶおよびこかんせついがい)	<u>75</u>
		下肢の静脈瘤	かしのじょうみゃくりゅう	<u>22</u>
		過食症	かしょくしょう	<u>53</u>
		下垂体腺腫	かすいたいせんしゅ	<u>57</u>
		風邪	かぜ	<u>62</u>
		肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)	かたかんせつしゅういえん(しじゅうかた・ごじゅうかた)	<u>72</u>
		過多月経	かたげつけい	<u>65</u>
		過敏性大腸炎	かびんせいだいちょうえん	<u>39</u>
		過敏性腸症候群	かびんせいちょうしょうこうぐん	<u>39</u>
		花粉症	かふんしょう	<u>35</u>
		加齢黄斑変性症	かれいおうはんへんせいしょう	<u>33</u>
		川崎病	かわさきびょう	<u>62</u>
		眼圧指摘	がんあつしてき	<u>32</u>
		肝炎(急性A型肝炎)	かんえん(きゅうせいえーがたかんえん)	<u>41</u>
		肝炎(急性B型肝炎)	かんえん(きゅうせいびーがたかんえん)	<u>42</u>
		肝炎(慢性C型肝炎)	かんえん(まんせいしーがたかんえん)	<u>42</u>
		肝炎(慢性B型肝炎)	かんえん(まんせいびーがたかんえん)	<u>42</u>
		肝機能異常	かんきのういじょう	<u>41</u>
		肝機能障害	かんきのうしょうがい	<u>41</u>
		ガングリオン	がんぐりおん	<u>72</u>
		肝血管腫	かんけっかんしゅ	<u>79</u>
		肝硬変	かんこうへん	<u>42</u>
		間質性肺炎	かんしつせいはいえん	<u>46</u>
		鉗子分娩	かんしぶんべん	<u>63</u>

		疾傷名	かな	ページ
か行 (続)	か	冠状静脈洞調律	かんじょうじょうみやくどうちょうりつ	<u>78</u>
		関節リウマチ(慢性)	かんせつりうまち(まんせい)	<u>73</u>
		乾癬(尋常性)	かんせん(じんじょうせい)	<u>69</u>
		完全右脚ブロック	かんぜんうきやくぶろっく	<u>78</u>
		肝臓癌	かんぞうがん	<u>58</u>
		眼底出血	がんでいしゅっけつ	<u>33</u>
		肝内結石	かんないけっせき	<u>79</u>
		肝内石灰化	かんないせっかい	<u>79</u>
		肝のう胞	かんのうほう	<u>79</u>
		肝膿瘍	かんのうよう	<u>43</u>
		顔面神経痛	がんめんしんけいつう	<u>30</u>
		顔面神経麻痺	がんめんしんけいまひ	<u>30</u>
	き	気管支炎(急性)	きかんしえん(きゅうせい)	<u>45</u>
		気管支炎(慢性)	きかんしえん(まんせい)	<u>45</u>
		気管支拡張症	きかんしかくちょうしょう	<u>45</u>
		気管支喘息	きかんしぜんそく	<u>46</u>
		(自然)気胸	(しぜん)ききょう	<u>45</u>
		気腫性変化	きしゅせいへんか	<u>78</u>
		ぎっくり腰(腰椎捻挫)	ぎっくりごし(ようついねんざ)	<u>76</u>
		逆流性食道炎	ぎゃくりゅうせいしょくどうえん	<u>38</u>
		吸引分娩	きゅういんぶんべん	<u>63</u>
		急性胃腸炎	きゅうせいいちようえん	<u>38</u>
		急性A型肝炎(A型肝炎)	きゅうせいえーがたかんえん(えーがたかんえん)	<u>41</u>
		急性気管支炎	きゅうせいきかんしえん	<u>45</u>
		急性硬膜下血腫	きゅうせいこうまくかけっしゅ	<u>74</u>
		急性骨髓炎	きゅうせいこつずいえん	<u>72</u>
		急性骨膜炎	きゅうせいこつまくえん	<u>72</u>
		急性糸球体腎炎	きゅうせいしきゅうたいじんえん	<u>48</u>
		急性腎不全	きゅうせいじんふぜん	<u>49</u>
		急性膀胱炎(原因不明の場合)	きゅうせいすいえん(げんいんふめいのばあい)	<u>43</u>
		急性前立腺炎	きゅうせいぜんりつせんえん	<u>51</u>
		急性中耳炎	きゅうせいちゅうじえん	<u>35</u>
		急性腸炎	きゅうせいちようえん	<u>38</u>
		急性肺炎	きゅうせいはいえん	<u>46</u>
		急性B型肝炎	きゅうせいびーがたかんえん	<u>42</u>
		急性副鼻腔炎	きゅうせいふくびくうえん	<u>35</u>
		急性扁桃炎	きゅうせいへんとうえん	<u>36</u>
		急性扁桃周囲炎	きゅうせいへんとうしゅういえん	<u>36</u>
		急性扁桃周囲膿瘍	きゅうせいへんとうしゅういのうよう	<u>36</u>
		境界域 Q 波	きょうかいいききゅうーは	<u>78</u>
		境界型糖尿病	きょうかいがたとうにようびょう	<u>25</u>
		狭心症	きょうしんしょう	<u>21</u>
		狭長体(痩せ)	きょうちょうたい(やせ)	<u>18</u>
		強迫性障害	きょうはくせいしょうがい	<u>53</u>
		胸部 X 線所見(健康診断)	きょうぶえつくすせんしよけん(けんこうしんだん)	<u>78</u>
		恐怖性障害	きょうふせいしょうがい	<u>53</u>
		胸膜炎(原因不明の場合)	きょうまくえん(げんいんふめいのばあい)	<u>45</u>
		胸膜肥厚	きょうまくひこう	<u>78</u>
		胸膜癒着	きょうまくゆちゃく	<u>78</u>
		虚血性心疾患	きよけつせいしんしっかん	<u>21</u>
		拒食症	きよしょくしょう	<u>53</u>

		疾傷名	かな	ページ
か行 (続)	き	巨赤芽球性貧血(悪性貧血)	きよせきがきゅうせいひんけつ(あくせいひんけつ)	<u>60</u>
		巨大レリーフ	きよだいれりーふ	<u>79</u>
		ギランバレー症候群	ぎらんばれーしょうこうぐん	<u>30</u>
		切れ痔(裂肛)	きれじ(れっこう)	<u>40</u>
		筋委縮性側索硬化症(ALS)	きんいしゆくせいそくさくこうかしょう(ALS)	<u>30</u>
		筋ジストロフィー	きんじすとろふいー	<u>73</u>
	く	クッシング症候群	くっしんぐしょうこうぐん	<u>26</u>
		クッシング病	くっしんぐびょう	<u>26</u>
		くも膜下出血	くもまくかしゅっけつ	<u>28</u>
		クラミジア	くらみじあ	<u>62</u>
		クローン病	くろーんびょう	<u>39</u>
		群発頭痛	ぐんぱつずつう	<u>29</u>
	け	頸管無力症	けいかんむりよくしょう	<u>63</u>
		憩室炎(小腸憩室、結腸憩室)	けいしつえん(しょうちようけいしつ、けっちようけいしつ)	<u>40</u>
		憩室症(小腸憩室、結腸憩室)	けいしつしょう(しょうちようけいしつ、けっちようけいしつ)	<u>40</u>
		頸椎捻挫(むち打ち症)	けいついねんざ(むちうちしょう)	<u>75</u>
		血圧	けつあつ	<u>19</u>
		血液検査結果	けつえきけんさけつか	<u>60</u>
		結核(肺)	けっかく(はい)	<u>62</u>
		月経異常(無月経、過多月経、月経困難、生理不順、PMS)	げっけいいじょう(むげっけい、かたげっけい、げっけいこんなん、せいりふじゅん、ぴーえむえす)	<u>65</u>
		月経困難	げっけいこんなん	<u>65</u>
		血色素量	けっしきそりょう	<u>60</u>
		血小板数(PLT)	けっしょうばんすう(PLT)	<u>60</u>
		結節影	けっせつえい	<u>78</u>
		結節性動脈周囲炎	けっせつせいどうみやくしゅういえん	<u>73</u>
		結腸憩室(憩室症・憩室炎)	けっちようけいしつ(けいしつしょう・けいしつえん)	<u>40</u>
		結腸癌	けっちようがん	<u>58</u>
		結膜炎	けつまくえん	<u>32</u>
		限局性強皮症(皮膚病変のみ)	げんきょくせいきょうひしょう(ひふびょうへんのみ)	<u>73</u>
		腱鞘炎	けんしょうえん	<u>72</u>
	こ	硬化影	こうかえい	<u>78</u>
		高眼圧症	こうがんあつしょう	<u>32</u>
		睾丸炎	こうがんえん	<u>51</u>
		膠原病(⇒膠原病と筋の異常)	こうげんびょう(⇒こうげんびょうときんのいじょう)	<u>73</u>
		高コレステロール血症	こうこれすてろーるけっしょう	<u>27</u>
		虹彩炎	こうさいえん	<u>32</u>
		高血圧(⇒血圧)	こうけつあつ(⇒けつあつ)	<u>19</u>
		高脂血症	こうしけっしょう	<u>27</u>
		後縦靱帯骨化症	こうじゅうじんたいこつかしょう	<u>71</u>
		甲状腺炎(慢性)	こうじょうせんえん(まんせい)	<u>26</u>
		甲状腺癌	こうじょうせんがん	<u>58</u>
		甲状腺機能亢進症	こうじょうせんきのうこうしんしょう	<u>26</u>
		甲状腺機能低下症	こうじょうせんきのうていかしょう	<u>26</u>
		甲状腺腫	こうじょうせんしゅ	<u>59</u>
		甲状腺腫大(手術を要しないもの)	こうじょうせんしゅだい(しゅじゅつをようしないもの)	<u>59</u>
		拘束型心筋症	こうそくがたしんきんしょう	<u>22</u>
		後天性免疫不全症候群(HIV)	こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん(HIV)	<u>61</u>
		喉頭癌	こうとうがん	<u>58</u>

		疾傷名	かな	ページ
か行 (続)	こ	高尿酸血症	こうようさんけっしょう	<u>26</u>
		更年期障害	こうねんきしょうがい	<u>65</u>
		高プロラクチン血症	こうぷろらくちんけっしょう	<u>65</u>
		硬膜下血腫(急性)	こうまくかけっしゅ(きゅうせい)	<u>74</u>
		硬膜下血腫(慢性)	こうまくかけっしゅ(まんせい)	<u>74</u>
		肛門癌	こうもんがん	<u>58</u>
		肛門周囲炎	こうもんしゅういえん	<u>40</u>
		肛門周囲膿瘍	こうもんしゅういのうよう	<u>40</u>
		股関節の骨折	こかんせつのこっせつ	<u>75</u>
		五十肩(肩関節周囲炎・四十肩)	ごじゅうかた(かたかんせつしゅういえん・しじゅうかた)	<u>72</u>
		骨腫瘍(良性のもの)	こつしゅよう(りょうせいのもの)	<u>59</u>
		骨粗しょう症	こつそしょうしょう	<u>71</u>
		骨髄炎(急性)	こつずいえん(きゅうせい)	<u>72</u>
		骨髄炎(慢性)	こつずいえん(まんせい)	<u>72</u>
		骨折(下肢)	こっせつ(かし)	<u>75</u>
		骨折(股関節)	こっせつ(こかんせつ)	<u>75</u>
		骨折(鎖骨)	こっせつ(さこつ)	<u>74</u>
		骨折(上肢)	こっせつ(じょうし)	<u>75</u>
		骨折(頭蓋骨)	こっせつ(ずがいこつ)	<u>74</u>
		骨折(脊椎)	こっせつ(せきつい)	<u>74</u>
		骨折(大腿骨)	こっせつ(だいたいこつ)	<u>75</u>
		骨折(大腿骨頸部)	こっせつ(だいたいこつけいぶ)	<u>75</u>
		骨折(膝関節部)	こっせつ(ひざかんせつぶ)	<u>75</u>
		骨折(肋骨)	こっせつ(ろっこつ)	<u>74</u>
		骨肉腫	こつにくしゅ	<u>58</u>
		骨膜炎(急性)	こつまくえん(きゅうせい)	<u>72</u>
		骨膜炎(慢性)	こつまくえん(まんせい)	<u>72</u>
さ行	さ	再生不良性貧血	さいせいふりょうせいひんけつ	<u>60</u>
		左脚前枝ブロック	さきやくぜんしぶろっく	<u>78</u>
		索状影	さくじょうえい	<u>78</u>
		鎖骨骨折	さこつこっせつ	<u>74</u>
		坐骨神経痛	ざこつしんけいとう	<u>76</u>
		左軸偏位	さじくへんい	<u>78</u>
		左室高電位	さしつこうでんい	<u>78</u>
		サルコイドーシス	さるこいどーしす	<u>47</u>
		三叉神経痛	さんさしんけいとう	<u>30</u>
		三尖弁逆流症	さんせんべんぎゃくりゅうしょう	<u>22</u>
		三尖弁狭窄症	さんせんべんきょうさくしょう	<u>22</u>
		三尖弁閉鎖不全症	さんせんべんへいさふぜんしょう	<u>22</u>
		霰粒腫	さんりゅうしゅ	<u>34</u>
	し	COPD(慢性閉塞性肺疾患)	しーおーぴーでいー(まんせいへいそくせいはいしっかん)	<u>45</u>
		C型肝炎(慢性)	しーがたかんえん(まんせい)	<u>42</u>
		シェーグレン症候群	しえーぐれんしょうこうぐん	<u>73</u>
		痔核	じかく	<u>40</u>
		耳下腺炎(流行性)	じかせんえん(りゅうこうせい)	<u>62</u>
		耳下腺膿瘍	じかせんのうよう	<u>37</u>
		子癇	しかん	<u>63</u>
		子宮外妊娠	しきゅうがいにんしん	<u>63</u>
		子宮癌	しきゅうがん	<u>58</u>
		子宮筋腫	しきゅうきんしゅ	<u>66</u>

		疾傷名	かな	ページ
さ行 (続)	し	子宮頸癌	しきゅうけいがん	<u>58</u>
		子宮頸管ポリープ	しきゅうけいかんぼりーぷ	<u>56</u>
		子宮頸管無力症	しきゅうけいかんむりよくしょう	<u>63</u>
		子宮頸部異形成	しきゅうけいふいけいせい	<u>57</u>
		子宮腺筋症	しきゅうせんきんしょう	<u>66</u>
		子宮体癌	しきゅうたいがん	<u>58</u>
		糸球体腎炎(急性)	しきゅうたいじんえん(きゅうせい)	<u>48</u>
		糸球体腎炎(慢性)	しきゅうたいじんえん(まんせい)	<u>48</u>
		子宮脱	しきゅうだつ	<u>65</u>
		子宮内膜異型増殖症	しきゅうないまくいけいぞうしょくしょう	<u>66</u>
		子宮内膜症	しきゅうないまくしょう	<u>66</u>
		子宮内膜増殖症	しきゅうないまくぞうしょくしょう	<u>66</u>
		子宮内膜ポリープ	しきゅうないまくぼりーぷ	<u>56</u>
		自己免疫性肝炎	じこめんえきせいかんえん	<u>42</u>
		死産	しざん	<u>63</u>
		脂質異常症	ししついじょうしょう	<u>27</u>
		四肢の骨折(⇒上肢・下肢の骨折)	ししのこっせつ(⇒じょうし・かしのこっせつ)	<u>75</u>
		四肢の脱臼	ししのだっきゅう	<u>77</u>
		四十肩(肩関節周囲炎・五十肩)	しじゅうかた(かたかんせつしゅういえん・ごじゅうかた)	<u>72</u>
		視神経炎	ししんけいえん	<u>31</u>
		視神経乳頭陥凹拡大	ししんけいにゅうとうかんおうかくだい	<u>32</u>
		自然気胸	しぜんききょう	<u>45</u>
		湿疹	しっしん	<u>69</u>
		失明	しつめい	<u>31</u>
		脂肪肝	しぼうかん	<u>43、79</u>
		脂肪腫	しぼうしゅ	<u>57</u>
		弱視	じゃくし	<u>31</u>
		斜視	しゃし	<u>31</u>
		縦隔腫瘍	じゅうかくしゅよう	<u>59</u>
		習慣性流産	しゅうかんせいりゅうざん	<u>63</u>
		重症筋無力症	じゅうしょうきんむりよくしょう	<u>73</u>
		十二指腸潰瘍	じゅうにしちようかいよう	<u>39</u>
		十二指腸潰瘍瘢痕	じゅうにしちようかいようはんこん	<u>79</u>
		十二指腸憩室	じゅうにしちようけいしつ	<u>79</u>
		手根管症候群	しゅこんかんしょうこうぐん	<u>72</u>
		腫瘍(悪性睾丸腫瘍)	しゅよう(あくせいこうがんしゅよう)	<u>58</u>
		腫瘍(骨腫瘍、良性のもの)	しゅよう(こつしゅよう、りょうせいのもの)	<u>59</u>
		腫瘍(縦隔腫瘍)	しゅよう(じゅうかくしゅよう)	<u>59</u>
		腫瘍(その他体表の良性腫瘍)	しゅよう(そのたたいひょうのりょうせいしゅよう)	<u>57</u>
		腫瘍(聴神経腫瘍)	しゅよう(ちょうしんけいしゅよう)	<u>59</u>
		上肢・下肢の骨折(大腿骨、膝関節部、大腿骨頸部および股関節以外)	じょうし・かしのこっせつ(だいたいこつ、ひざかんせつぶ、だいたいこつけいぶおよびこかんせついがい)	<u>75</u>
		掌蹠膿疱症	しょうせきのうほうしょう	<u>70</u>
		小腸憩室(憩室症・憩室炎)	しょうちようけいしつ(けいしつしょう・けいしつえん)	<u>40</u>
		食道癌	しょくどうがん	<u>58</u>
		食道憩室	しょくどうけいしつ	<u>79</u>
		食道静脈瘤	しょくどうじょうみゃくりゅう	<u>38</u>
		食道粘膜下腫瘍	しょくどうねんまくかしゅよう	<u>79</u>
		食道裂孔ヘルニア	しょくどうれっこうへるにあ	<u>38、79</u>

		疾傷名	かな	ページ
さ行 (続)	し	自律神経失調症	じりつしんけいしつちようしょう	<u>29</u>
		視力矯正手術	しりよくきようせいしゅじゅつ	<u>33</u>
		痔ろう	じろう	<u>40</u>
		腎移植(ドナー)	じんいしょく(どなー)	<u>49</u>
		腎移植(レシピエント)	じんいしょく(れしぴえんと)	<u>49</u>
		腎盂炎	じんうえん	<u>49</u>
		腎盂腎炎	じんうじんえん	<u>49</u>
		腎炎(急性系球体腎炎)	じんえん(きゅうせいしきゅうたいじんえん)	<u>48</u>
		腎炎(慢性)	じんえん(まんせい)	<u>48</u>
		腎炎(慢性系球体腎炎)	じんえん(まんせいしきゅうたいじんえん)	<u>48</u>
		心外膜炎	しんがいまくえん	<u>23</u>
		心筋梗塞	しんきんこうそく	<u>21</u>
		心筋症(拡張型)	しんきんしょう(かくちようがた)	<u>22</u>
		心筋症(拘束型)	しんきんしょう(こうそくがた)	<u>22</u>
		心筋症(肥大型)	しんきんしょう(ひだいがた)	<u>22</u>
		神経症	しんけいしょう	<u>29</u>
		神経性食欲不振症	しんけいせいしょくよくふしんしょう	<u>53</u>
		神経痛(顔面神経痛)	しんけいつう(がんめんしんけいつう)	<u>30</u>
		神経痛(坐骨神経痛)	しんけいつう(ざこつしんけいつう)	<u>76</u>
		神経痛(三叉神経痛)	しんけいつう(さんさしんけいつう)	<u>30</u>
		神経痛(肋間)	しんけいつう(ろっかん)	<u>30</u>
		腎血管筋脂肪腫	じんけっかんきんしぼうしゅ	<u>79</u>
		腎結石	じんけっせき	<u>50、79</u>
		腎硬化症	じんこうかしょう	<u>49</u>
		人工中絶	じんこうちゅうぜつ	<u>63</u>
		人工ペースメーカー挿入	じんこうペースめーかーそうにゅう	<u>23</u>
		腎周囲膿瘍	じんしゅういのうよう	<u>52</u>
		尋常性乾癬	じんじょうせいかんせん	<u>69</u>
		真性赤血球増加症	しんせいせつけっきゅうぞうかしょう	<u>60</u>
		真性多血症	しんせいいたけつしょう	<u>60</u>
		腎石灰化	じんせっかい	<u>79</u>
		腎臓癌	じんぞうがん	<u>58</u>
		靱帯損傷(膝関節を除く)	じんたいそんしょう(ひざかんせつをのぞく)	<u>76</u>
		心的外傷後ストレス障害(PTSD)	しんてきがいしょうごすとれすしょうがい(PTSD)	<u>53</u>
		心室中隔欠損症(VSD)	しんしつちゅうかくけつそんしょう(VSD)	<u>21</u>
		心臓弁膜症	しんぞうべんまくしょう	<u>22</u>
		心電図所見(健康診断)	しんでんずしょけん(けんこうしんだん)	<u>78</u>
		腎ドナー	じんどなー	<u>49</u>
		腎のう胞	じんのうほう	<u>79</u>
		腎膿瘍	じんのうよう	<u>52</u>
		深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群)	しんぶじょうみゃくけっせんしょう(えこのみーくらすし ょうこうぐん)	<u>22</u>
		心不全(慢性)	しんふぜん(まんせい)	<u>21</u>
		腎不全(急性)	じんふぜん(きゅうせい)	<u>49</u>
		腎不全(慢性)	じんふぜん(まんせい)	<u>49</u>
		心房細動(発作性)	しんぼうさいどう(ほっさせい)	<u>23</u>
		心房細動(慢性)	しんぼうさいどう(まんせい)	<u>23</u>
		心房中隔欠損症(ASD)	しんぼうちゅうかくけつそんしょう(ASD)	<u>21</u>
		心房調律	しんぼうちようりつ	<u>78</u>
		心膜炎	しんまくえん	<u>23</u>
		蕁麻疹	じんましん	<u>69</u>

		疾傷名	かな	ページ
さ行 (続)	す	肺炎(急性、原因不明の場合)	すいえん(きゅうせい、げんいんふめいのばあい)	<u>43</u>
		肺炎(慢性、原因不明の場合)	すいえん(まんせい、げんいんふめいのばあい)	<u>43</u>
		睡眠発作	すいみんほっさ	<u>53</u>
		水腎症	すいじんしょう	<u>49</u>
		脾石	すいせき	<u>79</u>
		脾臓癌	すいぞうがん	<u>58</u>
		脾臓(尾部)描出／観察不良	すいぞう(びぶ)びょうしゅつ／かんさつふりょう	<u>79</u>
		脾のう胞	すいのうほう	<u>79</u>
		髄膜炎	ずいまくえん	<u>29</u>
		髄膜腫	ずいまくしゅ	<u>59</u>
		睡眠時無呼吸症候群	すいみんじむこきゅうしょうこうぐん	<u>47</u>
		睡眠薬常用	すいみんやくじょうよう	<u>53</u>
		頭蓋骨骨折	ずがいこつこっせつ	<u>74</u>
		頭痛	ずつう	<u>29</u>
	せ	精液瘤	せいえきりゅう	<u>51</u>
		精索水瘤	せいさくすいりゅう	<u>51</u>
		正常分娩	せいじょうぶんべん	<u>63</u>
		精巣炎	せいそうえん	<u>51</u>
		精巣上体炎	せいそうじょうたいえん	<u>51</u>
		精巣水瘤	せいそうすいりゅう	<u>51</u>
		生体腎提供者	せいたいじんていきょうしゃ	<u>49</u>
		声帯ポリープ	せいたいぽりーぷ	<u>55</u>
		生理不順	せいらふじゅん	<u>65</u>
		脊柱管狭窄症	せきちゅうかんきょうさくしょう	<u>71</u>
		脊柱後弯症	せきちゅうこうわんしょう	<u>71</u>
		脊柱側弯症	せきちゅうそくわんしょう	<u>71</u>
		脊柱側弯	せきちゅうそくわん	<u>78</u>
		脊椎骨折(頸椎骨折を除く)	せきついこっせつ(けいついこっせつをのぞく)	<u>74</u>
		脊椎すべり症	せきついすべりしょう	<u>71</u>
		脊椎椎間板症	せきついついかんばんしょう	<u>71</u>
		脊椎分離症	せきついぶんりしょう	<u>71</u>
		石灰化(像)	せっかい(像)	<u>78</u>
		舌癌	ぜつがん	<u>58</u>
		切迫早産	せっぱくそうざん	<u>63</u>
		切迫流産	せっぱくりゅうざん	<u>63</u>
		線状影	せんじょうえい	<u>78</u>
		全身性エリテマトーデス(SLE)	ぜんしんせいえりてまとーです(SLE)	<u>73</u>
		全身性強皮症	ぜんしんせいきょうひしょう	<u>73</u>
		喘息	ぜんそく	<u>46</u>
		前置胎盤	ぜんちたいばん	<u>63</u>
		前立腺炎(急性)	ぜんりつせんえん(きゅうせい)	<u>51</u>
		前立腺炎(慢性)	ぜんりつせんえん(まんせい)	<u>51</u>
		前立腺癌	ぜんりつせんがん	<u>58</u>
		前立腺肥大症	ぜんりつせんひだいしょう	<u>51</u>
	そ	躁うつ病(⇒双極性障害)	そううつびょう(⇒そうきょくせいしょうがい)	<u>54</u>
		双極性障害(旧名:躁うつ病)	そうきょくせいしょうがい(きゅうめい:そううつびょう)	<u>54</u>
		早産	そうざん	<u>63</u>
		僧帽弁逸脱症	そうぼうべんいつだつしょう	<u>22</u>
		僧帽弁逆流症	そうぼうべんぎゃくりゅうしょう	<u>22</u>
		僧帽弁狭窄症	そうぼうべんきょうさくしょう	<u>22</u>
		僧帽弁閉鎖不全症	そうぼうべんへいさふぜんしょう	<u>22</u>

		疾傷名	かな	ページ
さ行 (続)	そ	鼠径ヘルニア	そけいへるにあ	<u>40</u>
		その他体表の良性腫瘍	そのたたいひょうのりょうせいしゅよう	<u>57</u>
た行	た	带状疱疹	たいじょうほうしん	<u>69</u>
		大腿骨頸部の骨折	だいたいこつけいぶのこっせつ	<u>75</u>
		大腿骨の骨折	だいたいこつのこっせつ	<u>75</u>
		大腿ヘルニア	だいたいへるにあ	<u>40</u>
		大腸癌	だいちょうがん	<u>58</u>
		大腸憩室(憩室症・憩室炎)	だいちょうけいしつ(けいしつしょう・けいしつえん)	<u>40</u>
		大腸ポリープ	だいちょうぽりーぷ	<u>55</u>
		耐糖能異常	たいとうのういじょう	<u>25</u>
		大動脈弓突出	だいどうみやくきゅうとっしゅつ	<u>78</u>
		大動脈の蛇行	だいどうみやくのだこう	<u>78</u>
		大動脈弁逆流症	だいどうみやくべんぎゃくりゅうしょう	<u>22</u>
		大動脈弁狭窄症	だいどうみやくべんきょうさくしょう	<u>22</u>
		大動脈弁閉鎖不全症	だいどうみやくべんへいさふぜんしょう	<u>22</u>
		大動脈瘤(胸部)	だいどうみやくりゅう(きょうぶ)	<u>21</u>
		大動脈瘤(腹部)	だいどうみやくりゅう(ふくぶ)	<u>21</u>
		胎盤早期剥離	たいばんそうきはくり	<u>63</u>
		唾石症	だせきしょう	<u>37</u>
		脱肛	だっこう	<u>40</u>
		脱腸	だっちょう	<u>40</u>
		多動性障害	たどうせいしょうがい	<u>54</u>
		多嚢胞性卵巣症候群	たのうほうせいらんそうしょうこうぐん	<u>66</u>
		多発性筋炎	たはつせいきんえん	<u>73</u>
		多発性硬化症	たはつせいこうかしょう	<u>30</u>
		多発性のう胞腎	たはつせいのうほうじん	<u>48</u>
		WBC(白血球数)	だぶりゅーびーしー(はつけっきゅうすう)	<u>60</u>
		WPW 症候群	だぶりゅーぴーだぶりゅーしょうこうぐん	<u>23</u>
		胆管癌	たんかんがん	<u>58</u>
		胆管結石(胆石症、胆のう結石)	たんかんけっせき(たんせきしょう、たんのうけっせき)	<u>44</u>
		胆石症(胆のう結石、胆管結石)	たんせきしょう(たんのうけっせき、たんかんけっせき)	<u>44</u>
		胆道癌	たんどうがん	<u>58</u>
		胆のう炎	たんのうえん	<u>44</u>
		胆嚢癌	たんのうがん	<u>58</u>
		胆のう結石(胆石症、胆管結石)	たんのうけっせき(たんせきしょう、たんかんけっせき)	<u>44</u> 、 <u>79</u>
		胆のう腺筋腫症	たんのうせんきんしゅしょう	<u>79</u>
		胆のう壁肥厚	たんのうへきひこう	<u>79</u>
		胆のうポリープ	たんのうぽりーぷ	<u>55</u> 、 <u>79</u>
		蛋白尿	たんぱくによう	<u>48</u>
	ち	蓄膿症	ちくのうしょう	<u>35</u>
		智歯	ちし	<u>37</u>
		注意欠陥障害	ちゅういけっかんしょうがい	<u>54</u>
		中耳炎(急性)	ちゅうじえん(きゅうせい)	<u>35</u>
		中耳炎(慢性)	ちゅうじえん(まんせい)	<u>35</u>
		中心性網膜症	ちゅうしんせいもうまくしょう	<u>31</u>
		中心性網脈絡膜症	ちゅうしんせいもうみやくらくまくしょう	<u>31</u>
		虫垂炎(盲腸)	ちゅうすいえん(もうちょう)	<u>40</u>
		聴神経腫瘍	ちようしんけいしゅよう	<u>59</u>

		疾傷名	かな	ページ
た行 (続)	ち	(人工)中絶	(じんこう)ちゅうぜつ	<u>63</u>
		腸閉塞(イレウス)	ちようへいそく(いれうす)	<u>38</u>
		直腸癌	ちよくちようがん	<u>58</u>
		直腸ポリープ	ちよくちようぼりーぷ	<u>55</u>
		チョコレート嚢胞	ちょこれーとのうほう	<u>66</u>
	つ	椎間板ヘルニア(頸椎・胸椎・腰椎)	ついかんばんへるにあ(けいつい・きょうつい・ようつい)	<u>71</u>
		痛風	つうふう	<u>26</u>
		悪阻(入院歴あり)	つわり(にゅういんれきあり)	<u>63</u>
	て	手足口病	てあしくちびよう	<u>70</u>
		TIA(一過性脳虚血発作)	ていーあいえー(いっかせいのうきょけつほっさ)	<u>28</u>
		帝王切開	ていおうせっかい	<u>63</u>
		定期健診における眼圧指摘	ていきけんしんにおけるがんあつしてき	<u>32</u>
		定期健診におけるピロリ菌陽性	ていきけんしんにおけるびろりきんようせい	<u>39</u>
		低電位差	ていでんいさ	<u>78</u>
		適応障害	てきおうしょうがい	<u>53</u>
		鉄欠乏性貧血	てつけつぼうせいひんけつ	<u>60</u>
		てんかん	てんかん	<u>30</u>
		伝染性単核球症	でんせんせいたんかくきゅうしょう	<u>41</u>
	と	統合失調症	とうごうしつちようしょう	<u>54</u>
		洞徐脈	どうじょみやく	<u>78</u>
		洞性不整脈	どうせいふせいみやく	<u>78</u>
		洞調律	どうちょうりつ	<u>78</u>
		糖尿病	とうにようびよう	<u>25</u>
		糖尿病(境界型)	とうにようびよう(きょうかいがた)	<u>25</u>
		頭部打撲	とうぶだぼく	<u>74</u>
		動脈管開存症	どうみやくかんかいぞんしょう	<u>23</u>
		透亮像	とうりょうぞう	<u>79</u>
		特発性血小板減少性紫斑病(ITP)	とくはつせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう(ITP)	<u>61</u>
		特発性脱疽	とくはつせいだっそ	<u>24</u>
		時計回転	とけいかいてん	<u>78</u>
		突発性難聴	とっぱつせいなんちょう	<u>36</u>
		とびひ	とびひ	<u>70</u>
		ドライアイ	どらいあい	<u>33</u>
な行	な	内耳炎	ないじえん	<u>35</u>
		内痔核	ないじかく	<u>40</u>
		ナルコレプシー	なるこれぶしー	<u>53</u>
	に	Ⅱ型糖尿病	にがたとうにようびよう	<u>25</u>
		肉腫	にくしゅ	<u>58</u>
		乳癌	にゅうがん	<u>58</u>
		乳管拡張症、乳管内乳頭腫	にゅうかんかくちようしょう、にゅうかんないにゅうとうしゅ	<u>68</u>
		乳腺炎	にゅうせんえん	<u>67</u>
		乳腺症、乳腺石灰化、乳腺線維腺腫、 乳腺嚢胞、乳房腺腫	にゅうせんしょう、にゅうせんせっかい、にゅうせんせんいせんしゅ、にゅうせんのうほう、にゅうぼうせんしゅ	<u>68</u>
		尿管結石	にょうかんけっせき	<u>50</u>
		尿潜血	にょうせんけつ	<u>48</u>
		尿糖	にょうとう	<u>25</u>
		尿道炎	にょうどうえん	<u>50</u>

		疾傷名	かな	ページ
な行 (続)	に	妊娠高血圧症候群	にんしんこうけつあつしょうこうぐん	<u>63</u>
		妊娠中	にんしんちゅう	<u>63</u>
		妊娠中毒症	にんしんちゅうどくしょう	<u>63</u>
		妊娠糖尿病	にんしんとうにようびょう	<u>25</u>
		認知症	にんちしょう	<u>29</u>
	ね	熱傷	ねっしょう	<u>69</u>
		ネフローゼ症候群(※既往のみ)	ねふろーぜしょうこうぐん(※きおうのみ)	<u>48</u>
		粘膜の不整	ねんまくのふせい	<u>79</u>
	の	膿痂疹	のうかしん	<u>70</u>
		膿胸	のうきょう	<u>45</u>
		脳梗塞(脳血栓・脳塞栓)	のうこうそく(のうけっせん・のうそくせん)	<u>28</u>
		脳挫傷	のうざしょう	<u>74</u>
		脳出血	のうしゅっけつ	<u>28</u>
		脳震盪	のうしんとう	<u>74</u>
		脳性(小児)麻痺	のうせい(しょうに)まひ	<u>29</u>
		脳卒中	のうそっちゅう	<u>28</u>
		脳動静脈奇形(脳ドック等で偶然発見された無症状のものを含みます。)	のうどうじょうみやくきけい(のうどっくなどでぐうぜんはっけんされたむしょうじょうのものをふくみます。)	<u>28</u>
		脳動脈瘤	のうどうみやくりゅう	<u>28</u>
		のう胞腎	のうほうじん	<u>79</u>
		のう胞腎(多発性)	のうほうじん(たはつせい)	<u>48</u>
は行	は	パーキンソン病	ぱーきんそんびょう	<u>30</u>
		バージャー病	ばーじゃーびょう	<u>24</u>
		肺炎(急性)	はいえん(きゅうせい)	<u>46</u>
		肺癌	はいがん	<u>58</u>
		肺気胸	はいききょう	<u>45</u>
		肺気腫	はいきしゅ	<u>45、78</u>
		肺結核	はいけっかく	<u>62</u>
		肺線維症	はいせんいしょう	<u>46</u>
		肺塞栓症	はいそくせんしょう	<u>46</u>
		肺動脈弁逆流症	はいどうみやくべんぎゃくりゅうしょう	<u>22</u>
		肺動脈弁狭窄症	はいどうみやくべんきょうさくしょう	<u>22</u>
		肺動脈弁閉鎖不全症	はいどうみやくべんへいさふぜんしょう	<u>22</u>
		肺のう胞	はいのうほう	<u>78</u>
		瀑状胃	ばくじょうい	<u>79</u>
		白癬	はくせん	<u>70</u>
		白内障	はくないしょう	<u>32</u>
		麦粒腫	ばくりゅうしゅ	<u>33</u>
		はしか	はしか	<u>62</u>
		橋本病	はしもとびょう	<u>26</u>
		バセドウ病	ばせどうびょう	<u>26</u>
		白血球数(WBC)	はっけつきゅうすう(WBC)	<u>60</u>
		白血病	はっけつびょう	<u>58</u>
		鼻茸	はなたけ	<u>35</u>
		鼻ポリープ	はなぼりーぷ	<u>35</u>
		パニック障害	ぱにっくしょうがい	<u>53</u>
		半月板損傷	はんげつばんそんしょう	<u>76</u>
		反時計回転	はんとけいかいてん	<u>78</u>
	ひ	PMS	ぴーえむえす	<u>65</u>
		B型肝炎ウイルスキャリア	ビーがたかんえんういるすきやりあ	<u>42</u>
		B型肝炎(急性)	ビーがたかんえん(きゅうせい)	<u>42</u>

		疾傷名	かな	ページ
は行 (続)	ひ	B型肝炎(慢性)	ビーがたかんえん(まんせい)	<u>42</u>
		PLT(血小板数)	ピーえるていー(けっしょうばんすう)	<u>60</u>
		PTSD(心的外傷後ストレス障害)	ピーていーえすでいー(しんてきがいのしょうごすとれすしょうがい)	<u>53</u>
		膝関節の靱帯損傷	ひざかんせつのじんたいそんしょう	<u>76</u>
		膝関節部の骨折	ひざかんせつぶのこっせつ	<u>75</u>
		肥大型心筋症	ひだいがたしんきんしょう	<u>22</u>
		鼻中隔湾曲症	びちゅうかくわんきょくしょう	<u>35</u>
		皮膚癌(悪性黒色腫を除く)	ひふがん(あくせいこくしよくしゅをのぞく)	<u>58</u>
		非ホジキンリンパ腫	ひほじきんりんぱしゅ	<u>58</u>
		肥満体	ひまんたい	<u>18</u>
		百日咳	ひやくにちぜき	<u>62</u>
		びらん性胃炎	びらんせいいえん	<u>79</u>
		ピロリ菌陽性	ぴろりきんようせい	<u>39</u>
		貧血(悪性貧血)	ひんけつ(あくせいひんけつ)	<u>60</u>
		貧血(巨赤芽球性貧血)	ひんけつ(きよせきがきゅうせいひんけつ)	<u>60</u>
		貧血(再生不良性貧血)	ひんけつ(さいせいふりようせいひんけつ)	<u>60</u>
		貧血(鉄欠乏性貧血)	ひんけつ(てつけつぼうせいひんけつ)	<u>60</u>
	ふ	ファロー四徴症	ふぁろーしちようしょう	<u>24</u>
		不安神経症	ふあんしんけいしょう	<u>53</u>
		VSD(心室中隔欠損症)	ふいえすでいー(しんしつちゅうかくけつそんしょう)	<u>21</u>
		風疹	ふうしん	<u>62</u>
		不完全右脚ブロック	ふかんぜんうきやくぶろっく	<u>78</u>
		副腎皮質機能不全(慢性)	ふくじんひしつきのうふぜん(まんせい)	<u>26</u>
		副脾	ふくひ	<u>79</u>
		副鼻腔炎(急性)	ふくびくうえん(きゅうせい)	<u>35</u>
		副鼻腔炎(慢性)	ふくびくうえん(まんせい)	<u>35</u>
		腹部エコー所見(健康診断)	ふくぶえこーしよけん(けんこうしんだん)	<u>79</u>
		腹膜炎	ふくまくえん	<u>40</u>
		不正出血	ふせいしゅつけつ	<u>65</u>
		不整脈	ふせいみやく	<u>22</u>
		不定軸	ふていじく	<u>78</u>
		ぶどう膜炎	ぶどうまくえん	<u>32</u>
		不妊症(女性)	ふにんしょう(じょせい)	<u>68</u>
		不妊症(男性)	ふにんしょう(だんせい)	<u>68</u>
		不眠症	ふみんしょう	<u>53</u>
		ブラ	ぶら	<u>78</u>
		フレグモーネ	ふれぐもーね	<u>70</u>
		ブレブ	ぶれぶ	<u>78</u>
		粉瘤	ふんりゅう	<u>57</u>
	へ	ベーチェット症候群	ペーちえつとしょうこうぐん	<u>73</u>
		閉塞性血栓血管炎	へいそくせいけっせんけつかんえん	<u>24</u>
		閉塞性動脈硬化症	へいそくせいどうみやくこうかしょう	<u>24</u>
		(人工)ペースメーカー挿入	(じんこう)ペーすめーかーそうにゅう	<u>23</u>
		ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	ヘのっほ・しえーんらいんしばんびょう	<u>61</u>
		ヘモグロビン(Hb)	へもぐろびん(Hb)	<u>60</u>
		変位腎	へんいじん	<u>52</u>
		変形性脊椎症	へんけいせいせきついしょう	<u>71</u>
		変形性膝関節症	へんけいせいひざかんせつしょう	<u>71</u>
		片頭痛	へんずつう	<u>29</u>
		便潜血	べんせんけつ	<u>41</u>

		疾傷名	かな	ページ
は行 (続)	へ	扁桃炎(急性)	へんとうえん(きゅうせい)	<u>36</u>
		扁桃炎(慢性)	へんとうえん(まんせい)	<u>36</u>
		扁桃周囲炎(慢性)	へんとうしゅういえん(まんせい)	<u>36</u>
		扁桃周囲炎(急性)	へんとうしゅういえん(きゅうせい)	<u>36</u>
		扁桃周囲膿瘍(急性)	へんとうしゅういのうよう(きゅうせい)	<u>36</u>
		便秘	べんぴ	<u>44</u>
	ほ	蜂窩織炎	ほうかしきえん	<u>70</u>
		膀胱炎	ぼうこうえん	<u>50</u>
		膀胱癌	ぼうこうがん	<u>58</u>
		膀胱結石	ぼうこうけっせき	<u>50</u>
		膀胱ポリープ	ぼうこうぼりーぷ	<u>59</u>
		房室接合部調律	ぼうしつせつごうぶちょうりつ	<u>78</u>
		胞状奇胎	ほうじょうきたい	<u>64</u>
		蜂巣炎	ほうそうえん	<u>70</u>
		ホジキン病	ほじきんびょう	<u>58</u>
		発作性心房細動	ほっさせいしんぼうさいどう	<u>23</u>
		ポリープ	ぼりーぷ	<u>35、55、56、59、79</u>
ま行	ま	埋伏智歯	まいふくちし	<u>37</u>
		マルファン症候群	まるふあんしょうこうぐん	<u>24</u>
		慢性アルコール中毒	まんせいあるこーるちゅうどく	<u>54</u>
		慢性胃炎	まんせいいえん	<u>38</u>
		慢性関節リウマチ	まんせいかんせつりうまち	<u>73</u>
		慢性気管支炎	まんせいきかんしえん	<u>45</u>
		慢性甲状腺炎	まんせいこうじょうせんえん	<u>26</u>
		慢性硬膜下血腫	まんせいこうまくかけっしゅ	<u>74</u>
		慢性骨髓炎	まんせいこつずいえん	<u>72</u>
		慢性骨膜炎	まんせいこつまくえん	<u>72</u>
		慢性C型肝炎	まんせいしーがたかんえん	<u>42</u>
		慢性糸球体腎炎	まんせいしきゅうたいじんえん	<u>48</u>
		慢性腎炎	まんせいじんえん	<u>48</u>
		慢性心不全	まんせいしんふぜん	<u>21</u>
		慢性腎不全	まんせいじんふぜん	<u>49</u>
		慢性心房細動	まんせいしんぼうさいどう	<u>23</u>
		慢性膵炎(原因不明の場合)	まんせいすいえん(げんいんふめいのばあい)	<u>43</u>
		慢性前立腺炎	まんせいぜんりつせんえん	<u>51</u>
		慢性中耳炎	まんせいちゅうじえん	<u>35</u>
		慢性B型肝炎	まんせいびーがたかんえん	<u>42</u>
		慢性副腎皮質機能不全	まんせいふくじんひしつきのうふぜん	<u>26</u>
		慢性副鼻腔炎	まんせいふくびくうえん	<u>35</u>
		慢性閉塞性肺疾患(COPD)	まんせいへいそくせいはいしっかん(COPD)	<u>45</u>
		慢性扁桃炎	まんせいへんとうえん	<u>36</u>
		慢性扁桃周囲炎	まんせいへんとうしゅういえん	<u>36</u>
	み	水虫	みずむし	<u>70</u>
		耳鳴	みみなり	<u>36</u>
		脈絡膜炎	みやくらくまくえん	<u>32</u>
	む	無月経	むげつけい	<u>65</u>
		むち打ち症(頸椎捻挫)	むちうちしょう(けいついねんざ)	<u>75</u>
	め	メニエール病	めにえーるびょう	<u>36</u>
		めまい	めまい	<u>36</u>
		メラノーマ(悪性黒色腫)	めらの一ま(あくせいこくしょくしゅ)	<u>58</u>

		疾傷名	かな	ページ
ま行 (続)	も	盲	もう	<u>31</u>
		盲腸(虫垂炎)	もうちょう(ちゅうすいえん)	<u>40</u>
		網膜色素変性症	もうまくしきそへんせいしょう	<u>33</u>
		網膜剥離	もうまくはくり	<u>32</u>
		網膜裂孔	もうまくれっこう	<u>32</u>
		網脈絡膜炎	もうみやくらくまくえん	<u>32</u>
		毛様体炎	もうようたいえん	<u>32</u>
		ものもらい	ものもらい	<u>33</u>
		モヤモヤ病	もやもやびょう	<u>28</u>
や行	や	火傷	やけど	<u>69</u>
		痩せ(狭長体)	やせ(きょうちょうたい)	<u>18</u>
	ゆ	遊走腎	ゆうそうじん	<u>52</u>
	よ	溶血性貧血	ようけつせいひんけつ	<u>60</u>
		腰椎捻挫(ぎっくり腰)	ようついねんざ(ぎっくりごし)	<u>76</u>
		腰痛	ようつう	<u>76</u>
		翼状片	よくじょうへん	<u>31</u>
ら行	ら	ラクナ梗塞	らくなこうそく	<u>28</u>
		卵巣癌	らんそうがん	<u>58</u>
		卵巣腫瘍	らんそうしゅよう	<u>67</u>
		卵巣のう腫	らんそうのうしゅ	<u>67</u>
	り	リウマチ性多発筋痛症	りうまちせいたはつきんつうしょう	<u>73</u>
		(関節)リウマチ	りうまち(かんせつりうまち)	<u>73</u>
		隆起性病変	りゅうきせいびょうへん	<u>79</u>
		流行性耳下腺炎	りゅうこうせいじかせんえん	<u>62</u>
		流産	りゅうざん	<u>63</u>
		緑内障	りょくないしょう	<u>32</u>
		淋病	りんびょう	<u>62</u>
	れ	レーシック	れーしっく	<u>33</u>
		レシipient(腎移植)	れしぴえんと(じんいしよく)	<u>49</u>
		裂肛(切れ痔)	れっこう(きれじ)	<u>40</u>
	ろ	肋間神経痛	ろっかんしんけいつう	<u>30</u>
		肋骨骨折	ろっこつこっせつ	<u>74</u>

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
体格	肥満体※	契約年齢	≪BMI≫					※左記の数値は“目安”です。あくまでも参考資料としてご利用ください。 ・16 歳未満は左記とは異なります。 ・客観的な資料による確認（医師の診査や健康診断結果表の提出）が必要になる場合があります。 ・BMI = 体重(kg)／(身長(m)×身長(m)) 【査定上のポイント】 ・原因不明の大きな体重変動等がある場合は（左表に関わらず）厳しい評価となります。
		16～39 歳	32 未満	○	○	○	○	
			32 以上 38 未満	割増	割増		×	
			38 以上 42 未満	割増	×		×	
			42 以上	×	×		×	
		40～59 歳	33 未満	○	○		○	
			33 以上 39 未満	割増	割増		×	
			39 以上 43 未満	割増	×		×	
			43 以上	×	×		×	
		60 歳～	34 未満	○	○		○	
			34 以上 40 未満	割増	割増		×	
			40 以上 44 未満	割増	×		×	
			44 以上	×	×		×	
	狭長体(痩せ)※	性別・契約年齢	≪BMI≫					※左記の数値は“目安”です。あくまでも参考資料としてご利用ください。 ・16 歳未満は左記とは異なります。 ・客観的な資料による確認（医師の診査や健康診断結果表の提出）が必要になる場合があります。 ・BMI＝ 体重(kg)／(身長(m)×身長(m)) 【査定上のポイント】 ・原因不明の大きな体重変動がある場合は（左表に関わらず）厳しい評価となります。
		男性 16～59 歳	16 以上	○	○	○	○	
			15 以上 16 未満	割増	割増	○	×	
			15 未満	×	×	×	×	
		男性 60 歳～	17 以上	○	○	○	○	
			15 以上 17 未満	割増	割増	○	×	
			15 未満	×	×	×	×	
		女性 16～59 歳	15 以上	○	○	○	○	
			15 未満	×	×	×	×	
		女性 60 歳～	16 以上	○	○	○	○	
			15 以上 16 未満	割増	割増	○	×	
			15 未満	×	×	×	×	

血圧	
【査定上のポイント】	・性別・年齢および収縮期と拡張期各々の血圧値により評価が異なります。（単位:mmHg） ・過去の血圧値が高い場合や心電図等に所見がある場合は下記とは異なる場合があります。 ・下記は死亡保障についての評価です。“○”と“×”については死亡保障も医療保障も同じですが、死亡保障が“割増”の場合、医療保障は“割増～×”となります。ガンは(基本的に)○となります。特定疾病は“×”となります。

【男性】

【0～39 歳】		拡張期血圧					
		-95	96-100	101-105	106-110	111-115	116-
収縮期 血圧	-119	○	割増～×	割増～×	割増～×	×	×
	120-140	○	割増	割増～×	割増～×	割増～×	×
	141-150	○～割増	割増	割増	割増	割増	×
	151-180	割増	割増	割増	割増	割増	×
	181-200	割増	割増	割増	割増	割増～×	×
	201-	×	×	×	×	×	×

【40～49 歳】		拡張期血圧					
		-95	96-100	101-105	106-110	111-115	116-
収縮期 血圧	-119	○	割増～×	割増～×	割増～×	×	×
	120-140	○	○	割増～×	割増～×	割増～×	×
	141-150	○	○～割増	割増	割増	割増	×
	151-160	○～割増	割増	割増	割増	割増	×
	161-180	割増	割増	割増	割増	割増	×
	181-200	割増	割増	割増	割増	割増～×	×
	201-	×	×	×	×	×	×

【50～59 歳】		拡張期血圧					
		-95	96-100	101-105	106-110	111-115	116-
収縮期 血圧	-119	○	割増～×	割増～×	割増～×	×	×
	120-140	○	○	割増～×	割増～×	割増～×	×
	141-150	○	○	割増	割増	割増	×
	151-160	○	○～割増	割増	割増	割増	×
	161-200	割増	割増	割増	割増	割増	×
	201-	×	×	×	×	×	×

【60 歳～】		拡張期血圧					
		-95	96-100	101-105	106-110	111-115	116-
収縮期 血圧	-119	○	割増～×	割増～×	割増～×	×	×
	120-140	○	○	割増～×	割増～×	割増～×	×
	141-150	○	○	○～割増	割増	割増	×
	151-160	○	○	割増	割増	割増	×
	161-180	○～割増	割増	割増	割増	割増	×
	181-200	割増	割増	割増	割増	割増	×
	201-	×	×	×	×	×	×

血圧	
【査定上のポイント】	・性別・年齢および収縮期と拡張期各々の血圧値により評価が異なります。（単位:mmHg） ・過去の血圧値が高い場合や心電図等に所見がある場合は下記とは異なる場合があります。 ・下記は死亡保障についての評価です。“○”と“×”については死亡保障も医療保障も同じですが、死亡保障が“割増”の場合、医療保障は“割増×”となります。ガンは(基本的に)○となります。特定疾病は“×”となります。

【女性】

【0～39 歳】		拡張期血圧					
		-95	96-100	101-105	106-110	111-115	116-
収縮期 血圧	-119	○	割増×	割増×	割増×	×	×
	120-140	○	割増	割増×	割増×	割増×	×
	141-150	○～割増	割増	割増	割増	割増	×
	151-160	割増	割増	割増	割増	割増	×
	161-180	割増	割増	割増	割増	割増	×
	181-200	割増	割増	割増	割増	割増×	×
	201-	×	×	×	×	×	×

【40～49 歳】		拡張期血圧					
		-95	96-100	101-105	106-110	111-115	116-
収縮期 血圧	-119	○	割増×	割増×	割増×	×	×
	120-140	○	○	割増×	割増×	割増×	×
	141-150	○	○～割増	割増	割増	割増	×
	151-160	○～割増	割増	割増	割増	割増	×
	161-180	割増	割増	割増	割増	割増	×
	181-200	割増	割増	割増	割増	割増×	×
	201-	×	×	×	×	×	×

【50～59 歳】		拡張期血圧					
		-95	96-100	101-105	106-110	111-115	116-
収縮期 血圧	-119	○	割増×	割増×	割増×	×	×
	120-140	○	○	割増×	割増×	割増×	×
	141-150	○	○	○～割増	割増	割増	×
	151-160	○	○	割増	割増	割増	×
	161-180	○～割増	割増	割増	割増	割増	×
	181-200	割増	割増	割増	割増	割増	×
	201-	×	×	×	×	×	×

【60 歳～】		拡張期血圧					
		-95	96-100	101-105	106-110	111-115	116-
収縮期 血圧	-119	○	割増×	割増×	割増×	×	×
	120-140	○	○	割増×	割増×	割増×	×
	141-150	○	○	○	割増	割増	×
	151-160	○	○	○～割増	割増	割増	×
	161-180	○～割増	○～割増	割増	割増	割増	×
	181-200	割増	割増	割増	割増	割増	×
	201-	×	×	×	×	×	×

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
循環器	狭心症 心筋梗塞 虚血性心疾患	発症時の年齢が 35 歳以下		×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・原則として、診査＋心電図が必要です。 追加で、健診結果（心電図検査結果を含むもの）や診断書が必要となる場合があります。（個別判断） ・発症時期、閉塞枝の数、治療内容、手術（バイパス術またはカテーテル）の有無、運動制限の有無等により査定します。 ・心エコーや心カテーテル等精密検査結果が良好であれば、緩和の可能性があります。 ・以下の場合はお引受困難です。 ・手術後 6 か月未満 ・2 回以上の心筋梗塞・狭心症の既往がある場合 ・ペースメーカーまたは除細動器の使用 ・糖尿病または脳卒中の合併
		発症時の年齢が 36 歳以上	発症後：1 年未満	×	×	○	×	
			発症後：1 年以上	割増～×	×	○	×	
	慢性心不全	現症/既往症		×	×	×	×	
	心 房 中 隔 欠 損 症 (ASD)	現症(手術前)		×	×	○	×	※以下の場合は個別判断となります。 ・申込時に未成年 ・20 歳以降に手術実施 ・後遺症、不整脈、肺高血圧等がある場合 【査定上のポイント】 原則として、診査＋心電図が必要です。 追加で、健診結果（心電図検査結果を含むもの）や診断書が必要となる場合があります。（個別判断）
		既往症(手術後、遺症なく完治したもの) ※						
		手術後：6 ヶ月未満		×	×	○	×	
		手術後：6 ヶ月以上 2 年未満		○	×	○	×	
		手術後：2 年以上		○	○	○	○	
	心 室 中 隔 欠 損 症 (VSD)	現症(手術前)		×	×	○	×	※手術後の評価は成人に対する目安で、未成年は別途個別判断となります。
		既往症(手術後)※						
		手術後 2 年未満		×	×	○	×	
		手術後 2 年 以上 かつ 後遺症なし	手術時年齢：5 歳未満	○	○	○	○	
			手術時年齢：5 歳以上	割増	割増～×	○	×	
		後遺症あり		×	×	○	×	
	大動脈瘤(腹部) 大動脈瘤(胸部) 解離性大動脈瘤	現症/既往症		×	×	○	×	※以下の条件を満たす経過良好なケース（但し胸部大動脈瘤は除く）については、診断書の提出によりお引受の検討ができる可能性はあります。但し高度条件付(割増)は確実です。（個別判断） ・手術後 1 年以上経過 ・合併症無し ・血圧・血糖・脂質コントロール良好 ・禁煙継続

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
循環器	[心臓弁膜症] 僧帽弁狭窄症 僧帽弁閉鎖不全症 僧帽弁逆流症 僧帽弁逸脱症 大動脈弁狭窄症 大動脈弁閉鎖不全症 大動脈弁逆流症 肺動脈弁狭窄症 肺動脈弁閉鎖不全症 肺動脈弁逆流症 三尖弁狭窄症 三尖弁閉鎖不全症 三尖弁逆流症	現症/既往症		割増 ～×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・原則として、診査＋心電図が必要です。追加で、健診結果（心電図検査結果を含むもの）や診断書が必要となる場合があります。（個別判断） ・診断名、心エコー所見（病変の範囲と程度）、原因、他の心疾患・不整脈の有無、手術内容（弁形成術 or 弁置換術）、処方薬剤名、合併症により個別に判断します。
	深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）	現症		×	×	○	×	【査定上のポイント】 複数回の発症がある場合、基礎疾患・後遺症がある場合は厳しい評価となります。 【告知のポイント】 発症時期、原因、治療内容（手術内容・薬剤名）、症状経過、後遺症の有無
		既往症（初回の発症で再発なく、基礎疾患・後遺症もない場合）	治癒後： 6ヵ月未満	×	×	○	×	
			治癒後： 6ヵ月以上 1年未満	割増	割増		×	
			治癒後： 1年以上	○	○		○	
	下肢の静脈瘤	現症		○	32 or 33 番 (3年)	○	×	
		既往症（手術後）	治癒後： 6ヵ月未満	○	32 or 33 番 (2年)	○	×	
			治癒後： 6ヵ月以上	○	○	○	○	
	不整脈	現症/既往症		－	－	－	－	【査定上のポイント】 不整脈には多くの種類があり、それぞれ評価が異なるため、正式な診断名（不整脈のタイプ）が必要です。診断書または心電図による確認が必要となる場合があります。
	肥大型心筋症 拡張型心筋症 拘束型心筋症	現症/既往症		×	×	○	×	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
循環器	(慢性)心房細動 発作性心房細動	現症/既往症		割増 ～×	×	○～×	×	【査定上のポイント】 ・心エコー等による精査未実施の場合は厳しい評価となります。 ・原因疾患が判明している場合は原因疾患による評価となります。 ・診断書が必要になる場合があります。 【告知のポイント】 正式診断名、発症時期、精査実施有無、原因、治療内容(薬剤名含む)、合併症
	人工ペースメーカー挿入	挿入後:3ヶ月未満		×	×	○～×	×	※ペースメーカー挿入の原因が心筋症・冠動脈疾患の場合、術後のフォローが不十分な場合、自動植込型除細動器(ICD)が適用となっている場合は×となります。 【査定上のポイント】 人工ペースメーカー挿入に至った原因疾患の確認が必要です。(原則として、診断書が必要です。)
		挿入後:3ヶ月以上		割増※ ～×	割増※ ～×			
	WPW 症候群	現症	過去に頻拍発作の既往なし	○	○	○	○	※アブレーション術で根治しなかった場合は現症(頻拍発作の既往あり)に準じた評価となります。 【査定上のポイント】 ・頻拍発作既往がある場合、原則として診断書が必要です。 ・心室細動の既往がある場合は死亡・医療ともに×となります。 【告知のポイント】 過去における頻拍発作の有無、手術(アブレーション術)の有無(時期)、手術済の場合は手術による根治の有無
			過去に頻拍発作の既往あり	割増 ～×	割増 ～×	○	×	
		既往症※ (アブレーション術後)	治癒後: 6ヵ月未満	割増 ～×	割増 ～×	○	×	
			治癒後: 6ヵ月以上	○	○	○	○	
	心膜炎 心外膜炎	現症		×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・診査+心電図が必要になる場合があります。 ・基礎疾患がある場合はその内容によります(個別判断となります)。 ・再発がある場合には厳しい評価になります。
		既往症	治癒後: 6ヵ月未満	×	×	○	×	
			治癒後: 6ヵ月以上	割増 ～○	割増 ～○	○	×～○	
	動脈管開存症	現症(手術前)		×	×	○	×	※ただし、合併症なし、症状なし、後遺症なしの場合に限ります。 【査定上のポイント】 診査+心電図が必要です。診断書が必要になる場合もあります。
		既往症 (手術後)	術後:1年未満	×	×	○	×	
			術後:1年以上※	○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
循環器	フロー四徴症	現症		×	×	○	×	【査定上のポイント】 診査+心電図が必要です。診断書が必要になる場合もあります。(個別判断)
		既往症	幼児期に根治術実施し、治癒後 10 年以上経過している場合	×～割増	×	○	×	
	マルファン症候群	現症/既往症		×	×	×	×	
	閉塞性動脈硬化症 閉塞性血栓血管炎 バージャー病 特発性脱疽	現症/既往症		割増～×	×～割増	○	×	【査定上のポイント】 ・原則として診断書が必要になります。(個別判断) ・重症度(症状の程度等)・治療内容・合併症等による個別判断となります。

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
尿糖・糖尿病	糖尿病	糖尿病のタイプ（Ⅰ型・Ⅱ型）、（発症）年齢、治療内容（薬剤名）、血糖コントロール状況（HbA1c 値・血糖値）、合併症の有無等に基づき判断します。						【査定上のポイント】 ・若年者ほど厳しい評価となります。 ・割増となっている個所は、割増+特障となる場合があります。 ・診査+血液検査もしくは健康診断結果（最近の血糖値を含むもの）の提出が原則として必要です。 ・診断書が必要となる場合があります（特にⅠ型糖尿病について） 【告知のポイント】 糖尿病のタイプ（Ⅰ型・Ⅱ型）、発症年齢、治療内容（薬剤名）、血糖コントロール状況（HbA1c 値・血糖値）、合併症の有無
	Ⅰ型糖尿病	現症：治療中 （医師の管理下にある場合）		×～ 割増	×	特障	×	
	Ⅱ型糖尿病 境界型糖尿病 耐糖能異常	現症：治療中または経過観察中		割増 ～×	割増 ～×	○～ 特障	×	
	Ⅰ型・Ⅱ型共通 （お引受困難な 場合）	・血糖コントロール不良の場合 ・糖尿病と診断（要治療）されているにもかかわらず放置（未治療）の場合		×～ 割増	×～ 割増	特障 ～○	×	
		・糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害がある場合 ・脳血管疾患・虚血性心疾患等の合併・既往がある場合		×	×	特障 ～○	×	
	妊娠糖尿病	妊娠中 ～分娩後1か月未満		×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・インスリン治療や妊娠に伴う合併症がある場合、血糖コントロール状況によっては左記基準より厳しい評価となる場合があります。 ・直近の HbA1c 数値が確認できる血液検査結果の提出が必要となります。 【告知のポイント】 治療内容（薬剤名含む）、治療期間血糖コントロール状況（HbA1c 値・血糖値）、合併症の有無
		分娩後 1か月以上		○～ 割増	○～ 割増	○	○～×	
	尿糖	健診指摘の場合	±	○	○	○	○	【査定上のポイント】 ・健康診断での尿糖指摘のみの場合に限りま
			+	割増	割増	○	×	す。
			++	割増	～×	○	×	・尿蛋白・肥満など他の検査項目で指摘がある場合、既往歴・現病歴がある場合は別途評価となります。
			+++以上	割増 ～×	×～ 割増	○	×	・原因疾患がある場合は、原因疾患による評価となります。

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
内分泌と代謝異常	甲状腺機能低下症	現症	服薬治療中または経過観察中（通院中）で甲状腺機能正常	○	5 番 (5 年)	○	○	【査定上のポイント】 ・原因疾患がある場合は別途評価となります（特に手術歴がある場合等）。
		既往症	治癒後:2 年未満	○	5 番 (2～5 年)	○	○	【告知のポイント】 原因(あれば)、治療内容(薬剤名)、症状の有無、コントロール状況(甲状腺ホルモン TSH、FT3、FT4 の数値)、合併症の有無
			治癒後:2 年以上	○	○	○	○	
	甲状腺機能亢進症 バセドウ病	現症	服薬治療中または経過観察中（通院中）で甲状腺機能正常	○	5 番 (全期間)	○	○	【査定上のポイント】 ・診査が必要になる場合があります。 ・原因疾患がある場合、合併症(心房細動・頻脈や甲状腺クリーゼ等)がある場合は別途評価となります。
		既往症	治癒後:5 年未満	○	5 番 (5 年)	○	○	【告知のポイント】 治療内容(薬剤名)、手術・放射線治療の有無、症状の有無、コントロール状況(甲状腺ホルモン TSH、FT3、FT4 の数値)、合併症の有無
			治癒後:5 年以上	○	○	○	○	
	橋本病 慢性甲状腺炎	現症	甲状腺機能正常 (無治療で経過観察中)	○	5 番 (5 年)	○	○	【告知のポイント】 治療内容(薬剤名)、症状の有無、コントロール状況(甲状腺ホルモン TSH、FT3、FT4 の数値)、合併症の有無
			甲状腺機能低下のため治療を要する場合	甲状腺機能低下症の項参照				
	アジソン病 慢性副腎皮質機能不全	治療中	治療開始後:1 年未満	×	×	×	×	※コントロール良好で合併症がない場合に限りです。
			治療開始後:1 年以上※	割増	×	○	×	【査定上のポイント】 原則として診断書が必要です。
	クッシング症候群 クッシング病	治療中		×～ 割増	×	○	×	【査定上のポイント】 原則として診断書が必要です(原因または原疾患、治療内容、コントロール状況、合併症等について確認が必要です)。
	高尿酸血症 痛風	現症/既往症	下記を全て満たす場合 ・腎機能障害なし ・尿酸値 9.9 mg/dl 以下 ・入院歴なし ・痛風性関節炎なし	○	○	○	○	【査定上のポイント】 左記以外の場合は個別判断となります。 【告知のポイント】 治療内容(薬剤名)、痛風発作の有無(および頻度)、最終発作時期、最近の尿酸値、腎機能障害の有無、合併症

分類	傷病名	判断条件	目安				補足
			死亡	医療	ガン	特定疾病	
内分泌と代謝異常	脂質異常症 高脂血症 高コレステロール血症	現症/既往症（健診指摘のみの場合を含む）					【査定上のポイント】 ・入院歴や他の疾患（合併症）がある場合は個別判断となります。 ・家族性高コレステロール血症と診断されている場合は別途評価となります。（診断書が必要になる場合があります） 【告知のポイント】 最近の脂質値（総コレステロール値、LDL コレステロール値、HDL コレステロール値、中性脂肪値）、治療内容（薬剤名）、合併症
		LDL コレステロール:179 以下 （LDL コレステロール値不明の場合は総コレステロール:299 以下） かつ 中性脂肪:399 以下	○	○	○	○	
		上記以外	○～×	○～×	○	○～×	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
脳血管疾患	脳卒中 脳梗塞 (脳血栓・脳塞栓) 脳出血	発症後	1 年未満	×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・原則として、診査が必要です。追加で、健診結果や診断書が必要となる場合もあります。(個別判断) ・後遺症(麻痺・てんかん等)の程度が査定上重要です。日常生活や歩行に支障が出る後遺症がある場合、お引受は困難です。 【告知のポイント】 発症時期・原因・手術有無(有の場合、手術内容)・入院期間・治療内容(薬剤名含む)・後遺症の有無(有の場合、その具体的内容と程度)・合併症有無
			1 年以上	× ～ 割増				
		手術が予定されている場合		×	×	×	×	
		2 回以上脳卒中を起こした場合		×	×	○	×	
		冠動脈疾患(心筋梗塞・狭心症等)がある場合						
		糖尿病がある場合		×	×	特障～○	×	
	ラクナ梗塞	脳ドック等による指摘のみの場合		割増	×	○	×	指摘を受けた健診結果の提出が必要です。
	くも膜下出血	既往症 (手術あり)	術後 6 カ月未満	×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・原則として、診査が必要です。追加で、健診結果や診断書が必要となる場合もあります。(個別判断) ・後遺症(麻痺・てんかん等)の有無および程度、血圧コントロール状況等により判断します。 【告知のポイント】 発症時期・原因・手術有無(有の場合、手術内容)・入院期間・治療内容(薬剤名)・後遺症の有無(有の場合、その具体的内容と程度)・合併症有無
			術後 6 カ月以上	割増～○	× ～ ○		× ～ ○	
		手術が予定されている場合		×	×	×	×	
		2 回以上脳卒中をおこした場合		×	×	○	×	
		冠動脈疾患(心筋梗塞・狭心症等)がある場合						
		糖尿病がある場合		×	×	特障～○	×	
	脳動脈瘤 脳動静脈奇形 (脳ドック等で偶然発見された無症状のものを含みます)	現症(未手術・経過観察中) ※		×	×	○	×	※術後に脳動脈瘤や脳動静脈奇形の残存がある場合を含みます。
		既往症	手術後:1 ヶ月未満	×	×	○	×	【査定上のポイント】 原則として診断書が必要です。指摘の経緯・数・大きさ・治療内容(手術内容含む)・残存する脳動脈瘤または脳動静脈奇形の有無・後遺症の有無含む術後経過により個別に判断します。
			手術後:1 ヶ月以上 (脳動脈瘤や脳動静脈奇形の残存がない場合に限ります)	○ ～ 割増	○ ～ ×	○	○ ～ ×	
	一過性脳虚血発作 (TIA)	既往症	治癒後:6 ヶ月未満	×	×	○	×	【査定上のポイント】 診査が必要です。診断書が必要となる場合があります。合併症等がある場合は別途評価となります。 【告知のポイント】 発症時期・発症回数・治療内容(薬剤名)・手術有無(有の場合、手術内容)・後遺症の有無(程度)・合併症有無
			治癒後:6 カ月以上	割増	×	○	×	
	モヤモヤ病	現症/既往症		×	×	○	×	

分類	傷病名	判断条件			目安				補足	
					死亡	医療	ガン	特定疾病		
神経系	脳性(小児)麻痺	6 歳未満			×	×	○	×	【査定上のポイント】 知的障害や運動障害の有無(程度)、社会生活への参加(就学・就労)状況等により個別判断となります。	
		6 歳以上			×	○		×		×
	アルツハイマー病	現症/既往症			×	×	×	×		
	認知症	現症/既往症			×	×	×	×		
	髄膜炎	現症			×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・後遺症の有無で判断します。 ・後遺症がある場合、後遺症の程度による個別判断となります。	
		既往症 (治癒後)	後遺症 なし	1 年未満	○	×		○		
				1 年以上	○	○		○		
			後遺症あり		割増 ～×	×		×		
	頭痛	精査あり(かつ異常なし) ※1、※2			○	○	○	○	※1 発症後3か月以内かつ症状が消失していない場合は、精査ありでも厳しい評価の可能性がありま す。 ※2 精密検査は脳神経外科で実施されていること が前提です(CT・MRI等による精査)。 【査定上のポイント】 原因疾患が判明している場合は、原因疾患によりま す。	
		精査なし	発症後： 6 ヶ月未満		×	×	×	×		
発症後：6 か月以上 2 年未満			割増	×	割増	×	○	×		
発症後： 2 年以上			○	○	○	○				
片頭痛 群発頭痛	現症/既往症			○～ 割増※	○～×	○	○～×	※重症と判断される場合×となる可能性がありま す。 【査定上のポイント】 ・精査(CT・MRI 等)実施の上で診断が確実な場合に 限ります。未精査の場合は“頭痛：精査なし”の項に よります。 ・治療内容、重症度、合併症の有無等により個別に 判断します。 【告知のポイント】 精査(CT・MRI 等)の有無、治療内容(薬剤名含む)、 発作の頻度と重症度(就労や日常生活への支障の 有無)、合併症(脳血管障害等)の有無、後遺症有無		
神経症 自律神経失調症	現症/既往症			割増 ～○	×	○	×	○	【査定上のポイント】 他の(精神)疾患との鑑別が重要になります。治療期 間、治療内容(薬剤名)、入院歴等により判断しま す。診断書が必要となる場合があります。 【告知のポイント】 治療開始時期、具体的症状、治療内容(薬剤名)、症 状経過	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
神経系	てんかん	欠神発作※1(小発作)のみ		○	割増～○	○	○	※1 短時間の意識消失(平均 10 秒) ※2 発作重積状態がある場合は厳しくなります(×～割増)。 ※3 原因となる基礎疾患が脳にあるもの(外傷・脳卒中・腫瘍等)(個別判断) ※4 脳腫瘍が原因(疑い含む)である場合は×となります。 【査定上のポイント】 ・精密検査実施済であることが前提です。 ・原因、発作のタイプ、発作の頻度(回/年)、治療内容、最終発作時期等により判断します。 ・事故歴がある場合、職種・職務の具体的内容等により、厳しい評価となる可能性があります。
		その他の発作※2 (症候性※3 は除く)	発症後: 1 年未満	×	×	○※4	×	【告知のポイント】 発症時期、精密検査実施有無、原因、発作のタイプ、発作頻度、最終発作時期、事故歴の有無、治療内容(薬剤名)
			発症後:1 年以上	割増～○	×～○	○※4	×～○	
		症候性※3		×～割増	×～割増	×～○	×	
	肋間神経痛 三叉神経痛 顔面神経痛	現症※		○	割増	○	○	※但し、下記の場合はすべて×となります。 ・発症後 1 年未満の場合 ・入院歴がある場合 ・症状が悪化傾向にある場合
		既往症	治癒後: 2 年未満	○	割増	○	○	
			治癒後: 2 年以上	○	○	○	○	
	顔面神経麻痺	現症		×	×	×	×	【査定上のポイント】 原因疾患がある場合は、原因に応じた評価となります。
		既往症	後遺症あり	○	割増	○	○	
			後遺症 治癒後: 2 年未満	○	割増	○	○	
			なし 治癒後: 2 年以上	○	○	○	○	
	ギランバレー症候群	現症		×	×	×	×	【査定上のポイント】 後遺症がある場合は、その内容に応じた個別判断となります。
		既往症 (後遺症 なし)	治癒後: 6 カ月未満	○	×	○	○	
			治癒後: 6 カ月以上	○	○	○	○	
	筋委縮性側索硬化症 (ALS)	現症/既往症		×	×	×	×	
	多発性硬化症	現症/既往症		×～割増	×	×～○	×	【査定上のポイント】 診断書が必要です。 但し診断書があっても×となる可能性があります。(個別判断)
	パーキンソン病	現症/既往症		×～割増	×	×～○	×	【査定上のポイント】 診断書が必要です。 但し診断書があっても×となる可能性があります。(個別判断)

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
感覚器 眼	盲 失明	原因疾患がない場合		○	○	○	○	【査定上のポイント】 原因疾患がある(または疑われる)場合は、原因疾患によります(個別判断となります)。 【告知のポイント】 原因・症状固定日・治療歴(あれば)
	弱視	原因疾患がない場合		特障	特障+1番 (全期間)	特障	特障	【査定上のポイント】 原因疾患がある(または疑われる)場合は、原因疾患によります(個別判断となります)。 【告知のポイント】 原因・症状固定日・現在の両眼の矯正視力
	斜視	先天性 現症		○	1番 (5年)	○	○	【査定上のポイント】 先天性以外の場合(原因疾患の存在が疑われる場合、視力障害がある場合など)は個別判断となります。
		先天性 既往症	治癒後(かつ手術済):1年未満	○	1番 (2年)	○	○	
			治癒後(かつ手術済):1年以上	○	○	○	○	
	翼状片	現症		○	1番 (3年)	○	○	【告知のポイント】 左右の別・手術の有無・完治時期
		既往症:手術済の場合		○	○			
	中心性網膜症 中心性網脈絡膜症	現症		特障	特障+1番 (5年)	特障	特障	【告知のポイント】 左右の別・治療内容・現在の両眼の矯正視力・再発の有無
		既往症	治癒後: 1年未満	特障	特障+1番 (2年)	特障	特障	
			治癒後: 1年以上	○	○	○	○	
	視神経炎	多発性硬化症の診断あり		多発性硬化症を参照				【査定上のポイント】 神経障害の有無、MRIなどの精密検査についての情報が必要です。 【告知のポイント】 神経障害の有無、左右の別・原因疾患の有無・治療内容・両眼の矯正視力
		多発性硬化症の診断なし	治癒後: 2年未満	特障～ 特障+割増	×	特障	特障～×	
			治癒後: 2年以上	特障	特障+1番 (5年)	特障	特障	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
感覚器 眼	白内障	現症		○	42 番※ (全期間)	○	○	※告知内容によっては、不担保部位が 1 番になる可能性があります。 【査定上のポイント】 原因疾患（糖尿病やアトピー性皮膚炎等）がある場合は、原因疾患の評価が加わります。 【告知のポイント】 原因・左右の別・手術有無（有の場合、左右どちらかまたは両眼か）・現在の両眼の矯正視力
		手術済（片眼のみ）		○				
		手術済（両眼）		○	○			
	結膜炎	現症/既往症		○	○	○	○	
	緑内障 高眼圧症 視神経乳頭陥凹拡大	現症/既往症		特障	特障+43 番 ※ (全期間)	特障	特障	※告知内容によっては、不担保部位が 1 番になる可能性があります。 【査定上のポイント】 原因疾患がある（または疑われる）場合は、原因疾患によります。 健診指摘の“視神経乳頭陥凹拡大”については、眼科専門医による精査（視野・眼圧・視力など）にて正常であれば○の可能性あります。
	定期健診における眼圧指摘※	眼圧 19mmHg 以下		○	○	○	○	※左記評価は、定期健康診断での眼圧指摘のみの場合に限りします。
		上記以外		特障～○	特障+1 番 (全期間)～ ○	特障～○	特障～○	【査定上のポイント】 症状、視力・眼底に所見や指摘がある場合は、個別判断となります。
	角膜炎 角膜潰瘍	現症 ※		特障	特障+1 番 (全期間)	特障	×	※全身性疾患が疑われる場合は厳しい評価となります。 【査定上のポイント】 原因疾患がある（または疑われる）場合は、原因疾患によります。 【告知のポイント】 原因・治療内容（薬剤名含む）・現在の両眼の矯正視力
		既往症	治癒後：2 年未満		特障+1 番 (2 年)		特障	
			治癒後：2 年以上	○	○	○	○	
	ぶどう膜炎 虹彩炎 毛様体炎 脈絡膜炎 網脈絡膜炎	現症		×	×	特障	×	【査定上のポイント】 原因疾患がある場合は、原因疾患によります（ペーチェット病・サルコイドーシス等の自己免疫疾患が原因となることがある）。また、白内障・緑内障・網膜剥離等を合併することもある（その場合は別途評価となります）。 【告知のポイント】 原因・治療内容（薬剤名含む）・現在の両眼の矯正視力・合併症有無
		既往症	治癒後：3 年未満 (合併症なし)	特障+割増	特障+1 番 (全期間 or 5 年)		×～特障	
			治癒後：3 年以上 (合併症なし)	○	○	○	○	
	網膜剥離 網膜裂孔	現症		×	×	特障	×	【査定上のポイント】 原因疾患がある（または疑われる）場合は、原因疾患によります。 【告知のポイント】 左右の別・原因・治療内容（手術内容・薬剤名含む）・再発有無・現在の両眼の矯正視力
		既往症	治癒後：5 年未満	特障	特障+1 番 (5 年)		特障	
			治癒後：5 年以上	○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
感覚器 眼	網膜色素変性症 黄斑変性症 加齢黄斑変性症	現症/既往症		特障	特障+1 番 (全期間)	特障	特障	【告知のポイント】 治療開始時期・治療内容(薬剤名含む)・現在の両眼の矯正視力
	黄斑前膜 黄斑上膜	現症		○	1 番 (5 年)	○	○	【査定上のポイント】 原因疾患がある(または疑われる)場合は、原因疾患によります。 【告知のポイント】 左右の別・原因・治療内容(手術内容・薬剤名含む)・再発有無・現在の両眼の矯正視力
		既往症	治療後(術後):2 年未満		1 番 (2 年)			
			治療後(術後):2 年以上		○			
	眼底出血	現症		×	×	特障	×	【査定上のポイント】 原因疾患がある(または疑われる)場合は、原因疾患によります。 【告知のポイント】 左右の別・原因・治療内容(手術内容・薬剤名含む)・再発有無・現在の両眼の矯正視力
		既往症	治療後:3 年未満	特障	特障+1 番 (5~3 年)	特障	×	
			治療後:3 年以上	○	○	○	○	
	円錐角膜	現症(未手術)		特障	特障+1 番 (全期間)	特障	特障	【告知のポイント】 左右の別・手術有無・現在の両眼の矯正視力
		既往症	治療後(かつ手術後): 2 年未満	特障	特障+1 番 (2 年)	特障	特障	
			治療後(かつ手術後): 2 年以上	○	○	○	○	
	レーシック 視力矯正手術	既往症	治療後:6 ヶ月未満	○	1 番 (1 年)	○	○	【告知のポイント】 手術時期・術後の治療内容(薬剤名含む)・現在の両眼の矯正視力
			治療後:6 か月以上	○	○			
	ドライアイ	現症/既往症		○	○	○	○	【査定上のポイント】 原因疾患(シェーグレン症候群等)がある場合は、原因疾患によります。 【告知のポイント】 原因・治療内容(薬剤名含む)・症状経過・視力障害の有無
	麦粒腫 ものもらい	現症		○	1 番 (1 年)	○	○	
		既往症		○	○			

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
感覚器 眼	霰粒腫	現症		○	1 番 (3～5 年)	○	○	
		既往症	治癒後:2 年未満	○	1 番 (2 年)			
			治癒後:2 年以上	○	○			

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
感覚器 耳鼻科	急性副鼻腔炎	既往症(治癒後)		○	○	○	○	
	慢性副鼻腔炎 蓄膿症	現症		○	44番※ (5年) ～×	○	○	※告知内容によっては、不担保部位 が3番になる可能性があります。
		既往症	治癒後(かつ手術後) :6ヵ月未満	○	44番※ (2年)	○	○	【告知のポイント】 治療内容と手術の有無
			治癒後(かつ手術後) :6ヶ月以上	○	○			
			治癒後(手術なし)	○	○～ 44番※ (2～5年)			
	鼻茸 鼻ポリープ	現症		○	3番 (5年)	○	○	【告知のポイント】 手術の有無、手術内容含む治療歴詳細、 完治時期
		既往症	治癒後(かつ手術後) :1年未満	○	3番 (2年)	○	○	
			治癒後(かつ手術後) :1年以上	○	○			
	アレルギー性鼻炎 花粉症	現症/既往症		○	○	○	○	
	鼻中隔湾曲症	現症		○	3番 (5年)	○	○	【告知のポイント】 手術の有無、手術内容含む治療歴詳細、 完治時期
		既往症: 治癒後(かつ手術後)		○	○			
	急性中耳炎※	現症		○	2番 (5年)	○	○	※治療期間が長い場合、再発を繰り返している場合は慢性で評価する可能性 があります。 【査定上のポイント】 真珠腫中耳炎が疑われる場合は、異なる 評価となります。 【告知のポイント】 手術の有無、治療内容、受診先医療 機関名
		既往症	治癒後:1年未満	○	2番 (2年)	○	○	
			治癒後:1年以上	○	○			
	慢性中耳炎	現症(未手術の既往症含む)		○～ 割増	2番 (5年 or 全期間)	○	○～×	
		既往症	治癒後(かつ手術後) :2年未満	○	2番 (2年)		○	
			治癒後(かつ手術後) :2年以上	○	○			
	内耳炎	現症		×	×	×	×	【査定上のポイント】 治療期間が長期の場合は個別判断 となります。 【告知のポイント】 原因、具体的な症状および経過、薬 剤名含む治療歴詳細、難聴等の後遺 症の有無
		既往症	治癒後:2年未満	○	2番 (2年)	○	○	
			治癒後:2年以上	○	○			

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
感覚器 耳鼻科	外耳炎	現症		○	2 番 (1 年)	○	○	
		既往症：治癒後			○			
	突発性難聴	現症※1		○	2 番 (5 年)	○	○	※1 精密検査後に診断されていることが前提です。 ※2 後遺症がある場合は個別判断となります。 【告知のポイント】 左右の別、実施した精密検査内容と精密検査結果、薬剤名含む治療歴、後遺症（難聴含む）有無
		既往症 ※1、2	治癒後：2 年未満	○	2 番 (2 年)			
			治癒後：2 年以上	○	○			
	耳鳴	現症	発症後：1 年未満	×	×	○	×	※治癒後でも発症後 1 年未満の場合は、現症 発症後 1 年未満と同様の評価となります。
			発症後：1 年以上	○	2 番 (3 年)	○	○	
		既往症	治癒後：2 年未満 ※	○	2 番 (2 年)	○	○	【査定上のポイント】 原因疾患、入院歴、手術歴、聴力障害などがある場合は個別判断となります。（厳しい評価になります）
			治癒後：2 年以上	○	○	○	○	
	めまい	発症後：1 年未満 ※		×	×	○	×	※精査済で原因疾患が否定されている場合は緩和検討可能です。（要診断書） 【査定上のポイント】 原因疾患がある場合は、原因疾患によります。コントロール不良の場合は個別判断 【告知のポイント】 原因、実施した検査内容と検査結果、薬剤名含む治療歴詳細、具体的な症状および経過、完治時期、後遺症有無
		発症後：1 年以上 3 年未満		○	割増		○	
		発症後：3 年以上		○	○		○	
	メニエール病	現症		○	2 番 (2 年)	○	○	【査定上のポイント】 精査後に診断されていることが前提です。 入院や手術がある場合は、個別判断となります。 【告知のポイント】 実施した検査内容と検査結果、薬剤名含む治療歴、具体的な症状および経過
		既往症	治癒後： 2 年未満	○	2 番 (2 年)	○	○	
			治癒後： 2 年以上	○	○	○	○	
	急性扁桃炎	現症		×	×	○	×	
		既往症：治癒後		○	○		○	
	急性扁桃周囲炎 急性扁桃周囲膿瘍	現症		×	×	○	×	※告知内容によっては、不担保部位が 6 番になる可能性があります。 【告知のポイント】 治療内容（薬剤名含む）、手術有の場合手術内容、症状経過
		既往症	治癒後： 1 年未満	○	45 番※ (2 年)	○	○	
			治癒後： 1 年以上	○	○			
	慢性扁桃炎 慢性扁桃周囲炎	現症		○	45 番※ (5 年)	○	○	※告知内容によっては、不担保部位が 6 番になる可能性があります。 【告知のポイント】 治療内容（薬剤名含む）、手術有の場合手術内容、症状経過
		既往症：治癒後（かつ手術後）		○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
感覚器耳鼻科	親知らず 埋伏智歯 智歯	現症※ 既往症		○	○	○	○	※抜歯予定がない場合に限りです。
	唾石症	現症		○	4 番 (5 年)	○	○	【告知のポイント】 治療内容(手術内容)・完治時期
		既往症	治癒後:2 年未満	○	4 番 (2 年)	○	○	
			治癒後:2 年以上	○	○			
	耳下腺膿瘍 (のうよう)	現症		×	×	○	×	
		既往症	治癒後:1 年未満	○	4 番 (2～5 年)		○	
			治癒後:1 年以上	○	○			

分類	傷病名	判断条件		目安				補足	
				死亡	医療	ガン	特定疾病		
消化器	食道静脈瘤	現症/既往症		×	×	×	×		
	逆流性食道炎 胃食道逆流症	現症	健診等での指摘のみ経過観察	○	8、38番 (2年)	○	○	【査定上のポイント】 ・左記評価は内視鏡により診断されていることが前提です(未精査で診断未確定の場合は別途評価となります)。 ・バレット食道の指摘や入院歴がある場合には別途評価となります。	
			投薬治療中	○	8、38番 (2～5年)	○～×	○		
		既往症	治癒後:1年未満	○	8、38番 (1年)	○	○	【告知のポイント】 内視鏡検査実施の有無と検査時期、治療内容、症状経過	
			治癒後:1年以上	○	○	○	○		
	食道裂孔ヘルニア	現症			○	38番 (全期間)	○	○	
		既往症	治癒後:2年未満		○	38番 (2年)	○	○	
			治癒後:2年以上		○	○	○	○	
	急性腸炎 急性胃腸炎※	既往症	治癒後:1ヵ月以上		○	○	○	○	※急性胃炎は胃炎で判断します。 【査定上のポイント】 数週間程度以内の投薬治療で治癒し、その後再発がないものに限ります。
	胃炎 慢性胃炎 胃酸過多症	現症	未精査 (内視鏡未実施)	発症後: 6ヶ月未満	×	×	×	×	※胃炎・慢性胃炎の場合は不担保(8番)のみとなります。 【査定上のポイント】 ・内視鏡検査の有無で異なります。 ・手術ありの場合、原則として診断書が必要です。(個別判断)
				6ヶ月以上	○	8、38番 (2～5年)※	○	○	【告知のポイント】 精査(内視鏡検査)の有無と実施時期、治療内容(薬剤名)、症状経過
			精査済(内視鏡検査済)		○	8、38番 (2～5年)※	○	○	
		既往症	治癒後:1年未満		○	8、38番 (1年)※	○	○	
			治癒後:1年以上		○	○	○	○	
	腸閉塞(イレウス)	手術なし	治癒後:3年未満		○	9、10、12番 (3～5年)	○	○	※手術ありの場合、原則として診断書が必要です。(個別判断) 【告知のポイント】 投薬・手術内容含む治療内容、入院歴がある場合はその期間、腸閉塞の原因(わかる場合)
			治癒後:3年以上		○	○	○	○	
		手術あり ※			○～×	○～×	○～×	○～×	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
消化器	胃潰瘍 十二指腸潰瘍	現症	未精査(内視鏡未実施)	×	×	×	×	【査定上のポイント】 ・入院歴がある場合は、厳しい評価となります。 ・精査(内視鏡検査)未実施の場合(疑いの場合等)はお引受困難です。 ・手術ありの場合、原則として診断書が必要です。(個別判断) 【告知のポイント】 精査(内視鏡検査)の有無と実施時期、治療内容(投薬名、入院歴、手術内容など)、症状経過
			精査済	割増	8番 (全期間)	○	×	
		既往症	治癒後:2年未満	○	8番 (2~5年)	○	○	
			治癒後:2年以上	○	○	○	○	
	定期健診におけるピロリ菌陽性 (ヘリコバクター・ピロリ菌陽性)※	ピロリ菌 除菌済み、または除菌中		○	○	○	○	※左記評価は、定期健康診断でのピロリ菌陽性指摘のみの場合に限ります。(ピロリ菌以外の指摘がある場合は個別判断となります。) 【査定上のポイント】 胃潰瘍・胃炎等の指摘・症状・治療歴等がある場合は、個別評価となります。 【告知のポイント】 胃内視鏡実施の有無、治療歴(除菌治療含む)がある場合はその詳細(治療期間、薬剤名、治療結果含む治療歴詳細)
		ピロリ菌 未除菌						
		精査(内視鏡) 実施済	ピロリ菌以外の指摘なし	○	○	○	○	
			ピロリ菌以外の指摘あり	○~×	○~×	○~×	○~×	
		精査(内視鏡) 未実施		○	8番 (2年)	×	×	
	過敏性腸症候群 過敏性大腸炎	現症	未精査 (内視鏡未実施)	×	×	×	×	【査定上のポイント】 精査(大腸内視鏡含む)未実施の場合はお引受困難です。 【告知のポイント】 精査(内視鏡検査)の有無と実施時期、治療内容(投薬名、手術内容など)、症状経過
			精査済	○	10、11番 (5年)	○	○	
		既往症	治癒後:2年未満	○	10、11番 (2年)	○	○	
			治癒後:2年以上	○	○	○	○	
	潰瘍性大腸炎 クローン病	現症/既往症(寛解後)		割増~×	×	×	×	※詳細な診断書などがあり軽度と判断される場合は、割増+不担保にてお引受できる可能性があります。 【査定上のポイント】 ・原則として診断書が必要です。(個別判断) ・発症年齢、病変範囲、症状経過、投薬・手術等治療内容、入院歴、合併症等の情報により個別に判断します。

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
消化器	虫垂炎(盲腸)	現症		×	×	×	×	【告知のポイント】 手術有無、治療内容、再発有無
		既往症	手術なし	○	9 番 (5 年) ～○	○	○	
			手術あり	○	○	○	○	
	憩室症・憩室炎 (小腸憩室・結腸憩室・大腸憩室)	現症※(症状あり)		×	×	×	×	※検査での偶発所見(無症状のもの)の場合はお引受の可能性あります。(個別判断) 【査定上のポイント】 ・手術実施例は(入院期間や経過期間により)診断書が必要となる場合があります。 ・再発や、穿孔による腹膜炎等がある場合は別途評価になります。 【告知のポイント】 具体的症状、検査内容、治療内容、手術の有無、再発の有無、合併症
		既往症 (手術なし)	治癒後:3ヶ月未満	×	×	○	×	
			治癒後:3ヶ月以上 2 年未満	○	該当部位 (2～5 年)	○	○	
			治癒後:2 年以上	○	○	○	○	
		既往症 (手術あり)	治癒後:3ヶ月未満	×	×	○～×	×	
			治癒後:3ヶ月以上	○	○	○～×	○	
	鼠径ヘルニア 大腿ヘルニア 脱腸	現症		○	35 番 (全期間)	○	○	【告知のポイント】 手術の有無
		既往症	手術なし	○		○	○	
			手術あり	○		○	○	
	痔核 内痔核 いぼ痔 裂肛(切れ痔) 脱肛 外痔核 肛門周囲炎 肛門周囲膿瘍 痔ろう	現症(未手術)		○	11 or 52 番 (5 年)	○	○	【査定上のポイント】 原因疾患(クローン病など)がある場合には、原因疾患による評価となります。 【告知のポイント】 原因疾患(指摘あれば)、治療内容(投薬内容)、手術の有無、症状経過
		既往症 (手術後)	治癒後:2 年未満	○	11 or 52 番 (1～2 年)	○	○	
			治癒後:2 年以上	○	○	○	○	
	腹膜炎	現症		×	×	×	×	※急性に発症し治癒した場合の評価です。慢性に経過している場合や別に原因疾患がある場合には別途評価となります。
		既往症※	治癒後:2 年未満	○	12 番 (2 年)	○	○	
			治癒後:2 年以上	○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
消化器	便潜血	精密検査※1 実施、かつ、異常なし※2 の場合		○※2	○※2	○※2	○※2	※1 精密検査とは、大腸内視鏡検査、大腸CT検査、注腸X線検査を指します。 便潜血再検査・直腸診・直腸鏡による検査の場合は、精密検査未実施で判断します。 ※2 精密検査の結果、何も所見がなかった場合に限りです。大腸ポリープ等の所見があった場合はその内容によります（診断書が必要になる場合があります）。 【告知のポイント】 精密検査（大腸内視鏡検査・大腸CT検査・注腸X線検査）実施の有無、検査での所見の有無（有の場合その詳細）、医師の指示など
		精密検査※1 未実施の場合		×	×	×	×	
		ただし、精密検査※1 未実施の場合でも、便潜血陽性指摘以降の定期健康診断にて、毎年便潜血陰性が確認できる場合						
		（最近の陽性指摘から）						
		39 歳以下	1 年未満	×	×	×	×	
			1 年以上 2 年未満	削減	10 番（2 年）	×	×	
			2 年以上	○	○	○	○	
		40 歳以上	2 年未満	×	×	×	×	
			2 年以上 3 年未満	削減	10 番（2 年）	×	×	
			3 年以上	○	○	○	○	
	肝機能異常 肝機能障害	健康診断での指摘のみ （通院・治療歴なし）	AST(GOT)・ALT(GPT)が、ともに 59IU/l以下 かつ γ-GTP119IU/l以下	○	○	○	○	【査定上のポイント】 ・慢性肝炎（肝炎既往のある場合も含みます）、肝炎ウイルスキャリア、通院中、治療中等の場合は適用できません。 ・原則として指摘を受けた健康診断結果の提出が必要です。
			上記以外	割増～×	13 番（5 年 or 全期間）～×	○～×	×	
		治療中		（治療中の肝疾患で評価）				
	急性A型肝炎 （A型肝炎）	既往症	治癒後：3 ヶ月未満	×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・お引受は、肝機能が正常範囲に回復し、かつ後遺症がないことが前提です。 ・原則として最近の肝機能数値（AST、ALT、γ GTP）の確認が必要です。
			治癒後：3 ヶ月以上	○	○	○	○	
		既往症 （劇症肝炎後）	治癒後：2 年未満	×	×	○	×	
			治癒後：2 年以上	○	○	○	○	
	伝染性単核球症 EBウイルス肝炎	既往症	治癒後：3 ヶ月未満	×	×	○	×	
			治癒後：3 ヶ月以上	○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
消化器	B型肝炎ウイルスキャリア	下記は除きます ・現在治療中 ・過去に治療歴がある ・肝機能異常がある		割増～○	×～○	×～○	×～○	【査定上のポイント】 ・お引受は、今までに肝炎・肝機能異常での治療歴がなく、かつ肝機能が正常範囲であることが前提です。 ・最近の肝機能検査数値（AST、ALT、γGTP）およびB型肝炎マーカー（HBsとHBeの抗原/抗体）の確認が必要です。肝機能異常がある場合は、慢性B型肝炎での評価となります。
	急性B型肝炎	既往症	治癒後:6ヶ月未満	×	×	×	×	【査定上のポイント】 お引受は、肝機能が正常範囲に回復していることが前提です。原則として最近の肝機能数値（AST、ALT、γGTP）の確認が必要です。 肝機能異常がある場合は慢性B型肝炎での評価となります。
			治癒後:6ヶ月以上	○～割増	13番 (5年 or 全期間)～○	○～×	○～×	
	慢性B型肝炎	現症※	治療中※ または経過観察中	×～割増	×	×	×	※抗ウイルス薬もしくはインターフェロンによる治療中は×となります。 【査定上のポイント】 ・原則として、最近の肝機能検査数値（AST、ALT、γGTP）および肝炎ウイルスマーカーの確認が必要です。追加で、診断書（診断名、薬剤名含む治療内容、最近の肝機能数値、肝炎ウイルスマーカー、腫瘍マーカー、腹部エコーやCT等画像診断結果、合併症等を含むもの）が必要な場合があります。（個別判断）
		既往症	治癒後:1年未満	割増	×	×	×	
			治癒後:1年以上	○～割増	○～×	○～×	○～×	
	慢性C型肝炎	現症※	治療中※ または経過観察中	×～割増	×	×	×	・既往症でも肝機能異常がある場合は現症に準じた評価になります。 ・肝硬変や肝がんを合併する場合は引受不可となります。
		既往症 (HCV-RNA 陰性化後)	治癒後:1年未満	割増	×	×	×	
			治癒後:1年以上	割増～○	×～○	×～○	×～○	
	アルコール性肝炎	現症/既往症		×	×	×	×	
	肝硬変	現症/既往症		×	×	×	×	
	自己免疫性肝炎	現症/既往症		×	×	×	×	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
消化器	脂肪肝※	健康診断での指摘のみ (通院・治療歴なし)		肝機能異常で評価				※非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)と診断されている場合は除きます(個別判断)。 【査定上のポイント】 ・脂肪肝と診断されている前提です(ウイルス性肝炎等他の肝疾患を合併している場合は別途評価)。 ・原則として最近の肝機能数値(AST、ALT、γGTP)の確認が必要です。治療歴がある場合、診断書が必要になる場合があります。 【告知のポイント】 指摘の経緯、検査内容と検査結果、治療内容(薬剤名含む)
		上記以外(現症/既往症)		○～割増	○～×	○	○～×	
	肝膿瘍	現症		×	×	×	×	【査定上のポイント】 後遺症がない場合に限ります。
		既往症	治癒後:1年未満	○	×	○	○	
			治癒後:1年以上 3年未満	○	13番 (3～5年)	○	○	
			治癒後:3年以上	○	○	○	○	
	急性膵炎 (原因不明の場合)	現症		×	×	×	×	【査定上のポイント】 ・原因が判明している場合は原因による評価となります。 ・診断書が必要になる場合があります。 ・アルコールが原因の場合、再発がある場合等は厳しい評価となります。
		既往症	治癒後:6ヶ月未満	×	×	○～×	×	
			治癒後:6ヶ月以上 3年未満	割増	14番 (5年 or 全期間)～×	○～×	×	
			治癒後:3年以上	○	14番 (3～5年)～○	○	○～×	
	慢性膵炎 (原因不明の場合)	現症		×	×	×	×	【査定上のポイント】 ・一般にお引受の難しい疾患です。 ・原則として、診断書が必要になります。(個別判断) ・原因疾患がある場合、合併症がある場合等は別途評価になります(引受不可の可能性もあります)。 ・アルコールが原因の場合はすべて×となります。
		既往症	治癒後:2年未満	×	×	×	×	
			治癒後:2年以上 5年未満	割増	×	○～×	×	
			治癒後:5年以上	○～割増	○～×	○～×	×	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
消化器	胆石症 (胆のう結石、 胆管結石)	現症		○	50 番※ (5 年)	○	○	※告知内容によっては、不担保部位が 13 番になる可能性があります。 【査定上のポイント】 ・複数回の胆石(疼痛・胆嚢炎)発作があり経過が浅い(1 年以内)場合は、厳しい評価となります。 ・肝内結石症や総胆管結石症(で結石の残存がある場合は)は厳しい評価となります。
		既往症	胆のう摘出術なし	○	50 番※ (5 年)	○	○	【告知のポイント】 胆石の部位(正式診断名)、治療内容、手術済の場合は術式(腹腔鏡手術 or 開腹手術)
			胆のう摘出術あり 完治後:1 年未満	○	13 番 (2 年)	○	○	
			胆のう摘出術あり 完治後:1 年以上	○	○	○	○	
	胆のう炎	現症		×	×	×	×	※1 手術ありの場合、術式・入院期間等による個別判断となります(診断書が必要になる場合があります)。
		既往症 (手術なし)	治癒後:2 年未満	○	50 番 ※2 (2~5 年)	○	○	※2 告知内容によっては、不担保部位が 13 番になる可能性があります。
			治癒後:2 年以上	○	○	○	○	
		既往症(手術あり)※1		○~×	○~×	○~×	○~×	
	便秘	発症後: 1 年未満	精密検査未実施	×	×	×	×	※1 40 歳未満で、治療内容、症状経過などに問題がない場合は緩和となる可能性があります。
			精密検査実施済					※2 原因疾患、基礎疾患がある場合は、個別判断となります。
			異常なし	○	○	○	○	【告知のポイント】 発症時期、精密検査実施の有無、検査での所見の有無(有の場合その詳細)、治療内容(薬剤名)、原因、症状経過など
			異常あり※2	×~○	×~○	×~○	×~○	
		発症後:1 年以上 かつ 状態が安定している場合 ※2		○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
呼吸器	自然気胸 肺気胸	現症		×	×	○	×	【査定上のポイント】 発作回数や手術内容によっては緩和となる可能性があります。 【告知のポイント】 治療内容(手術内容含む)、再発有無(発作回数)
		既往症	治癒後:2年未満	○～割増	46番 (2～3年)～ ○	○	○～×	
			治癒後:2年以上	○	○	○	○	
	膿胸	既往症	治癒後:6ヶ月未満	×	×	○	×	
			治癒後:6ヶ月以上 1年未満	○	7番 (2年)	○	○	
			治癒後:1年以上	○	○	○	○	
	胸膜炎 (原因不明の場合)	既往症	治癒後:6ヶ月未満	×	×	○	×	【査定上のポイント】 原因が判明している場合は、原因疾患による評価になります。(感染症・悪性腫瘍・膠原病などが原因になる場合があります)
			治癒後:6ヶ月以上 1年未満	○	7番 (2年)	○	○	
			治癒後:1年以上	○	○	○	○	
	慢性閉塞性肺疾患 (COPD) 肺気腫 慢性気管支炎 気管支拡張症	現症/既往症		割増～×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・最近の肺機能検査結果(1秒率や%肺活量等)の情報により重症度を判定します。 ・原則として上記情報を含む診断書等が必要になります。 ・肺高血圧症・冠動脈疾患を合併している場合、在宅酸素療法を行っている場合、喫煙習慣の継続がある場合等は×となります。 【告知のポイント】 正式診断名、治療内容(薬剤名含む)、具体的症状および経過、合併症有無、喫煙歴
	急性気管支炎	現症		×	×	×	×	※入院歴がある場合は個別判断となります。
		既往症(治癒後)※		○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
呼吸器	喘息(ぜんそく) 気管支喘息	現症/既往症		○～割増 ※	○～7 番 (2～5 年 or 全期間)※	○	○～×	※重症と判断される場合は×となる可能性があります。 【査定上のポイント】 ・発作の頻度、夜間発作の有無、入院・救急受診歴、投薬の種類等の情報により重症度を判定します。 ・他の呼吸器疾患(COPD 等)の合併が増えるため、高齢者の引受は若年者よりも厳しくなります。 【告知のポイント】 ・発作の頻度、夜間発作の有無、入院・救急受診歴(あればその詳細)、投薬の種類(薬剤名)
	(急性)肺炎	既往症(治癒後)		○	○	○	○	【査定上のポイント】 再発がある場合、その他原因疾患がある場合は個別判断となります。
	間質性肺炎 肺線維症	現症/既往症		×	×	×	×	
	肺塞栓症	既往症 (再発無)	治癒後:6ヶ月未満 治癒後:6ヶ月以上 1年未満 治癒後:1年以上	× ○ ○	× × ○	× ○ ○	× × ○	【査定上のポイント】 ・再発がある場合は別途評価となります。 ・原因が判明している場合は、原因疾患による評価となります。

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
呼吸器	睡眠時無呼吸症候群	現症/既往症		○～割増 ※	○～割増 ※	○	○～×	※重症と判断される場合は×となる可能性があります。 【査定上のポイント】 ・無呼吸指数(AI)・無呼吸低呼吸指数(AHI)などの精査結果により重症度を判定します。 ・上記情報を含む診断書が必要となる場合があります。 ・合併症がある場合は別途その評価が必要になります。 【告知のポイント】 治療内容(CPAPや口蓋形成術など)、治療期間、合併症の有無 ・無呼吸指数(AI)・無呼吸低呼吸指数(AHI)も分かれば、よりの確な査定が可能です。
	サルコイドーシス	現症/既往症	診断後:1年未満	×	×	×	×	【査定上のポイント】 ・原則として診断書が必要です。 ・診断後の経過と病変範囲、それに伴う機能障害の程度により判断します。 ・肺以外の病変がある場合は個別判断となります。ただし心臓・神経系・肝臓・腎臓に病変がある場合は引受困難です。 【告知のポイント】 病変の範囲、治療内容(薬剤名)
			診断後:1年以上	○～×	○～×	○～×	○～×	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足	
				死亡	医療	ガン	特定疾病		
泌尿器	蛋白尿※	健診指摘 (69 歳以下)	-/±	○	○	○	○	※健康診断での尿蛋白指摘のみの場合に限ります。他の検査項目で指摘がある場合や、既往歴・現病歴がある場合は別途評価となります。	
			+	割増	割増 女疾: ×		×		
			++	割増	割増 女疾: ×		×		
			+++以上	×	×		×		
		健診指摘 (70 歳以上)	-/±	○	○	○	○		
			+	○	○		○		
			++	割増	割増 女疾: ×		×		
			+++以上	割増～×	割増～×		女疾: ×		×
	尿潜血※	健診指摘 (男性)	-/±	○	○	○	○	※健康診断での尿潜血指摘のみの場合に限ります。他の検査項目で指摘がある場合や、既往歴・現病歴がある場合は別途評価となります。	
			+ / ++	割増	割増		×		
			+++	×	×	×	×		
		健診指摘 (女性)	- / ± / + / ++	○	○	○	○		
			+++	×	×	×	×		
	急性糸球体腎炎	現症		×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・診査もしくは最近の健康診断結果が必要です。 ・尿検査・血圧値等に異常がある場合、長期の通院歴がある場合等は個別判断となります。	
		既往症	治癒後: 1 年未満		×		×		×
			治癒後: 1 年以上 2 年未満		○		15 番 (2～5 年)		○
			治癒後: 2 年以上		○		○		○
	慢性糸球体腎炎 IgA 腎症 慢性腎炎 ※ネフローゼ症候群 (※既往のみ)	現症/ 既往症	腎機能検査(クレアチニン、BUN)・血圧値がいずれも 正常範囲内 かつ尿蛋白2+以下						【査定上のポイント】 ・診査および血液検査(もしくは腎機能検査結果を含む最近の健康診断結果)が必要です。 ・診断書が必要となる場合があります。診断書には、診断名(腎生検結果)、発症年齢、治療内容(薬剤名)、経過、最近の腎機能検査結果、合併症などの情報が必要です。
			診断後: 2 年未満		割増～×	×	○	×	
			診断後: 2 年以上 10 年未満		割増	×	○	×	
			診断後: 10 年以上		割増～○	×	○	×	
			上記条件以外		×	×	×	×	
	(多発性)のう胞腎	現症/既往症		×	×	×～○	×	【査定上のポイント】 ・一般的にお引受の難しい疾患です。 ・健康診断で指摘され(通常)経過観察判定となる“腎のう胞”とは異なります。	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
泌尿器	急性腎不全	現症		×	×	×	×	※尿検査・血圧値いずれも正常の場合 【査定上のポイント】 ・原則として、診査が必要です。追加で、健診結果や診断書が必要となる場合があります。 ・原因疾患がある場合は別途評価が必要です。
		既往症※	治癒後:1年未満	×	×	○	×	
			治癒後:1年以上	○	○	○	○	
	慢性腎不全	現症/既往症		×	×	×	×	
	水腎症	現症(未手術)※		×～○	×～15番 (5年 or 全期間)	×～○	×～○	※現症の場合、原則として診断書が必要です。(原因・状態等により個別判断) 【査定上のポイント】 原則として、診査が必要です。追加で、健診結果や診断書が必要となる場合もあります。水腎症の原因によっては別途評価となります。 【告知のポイント】 原因、左右の別、治療内容(手術内容)、現在の状態、最近の検査結果
		既往症 (手術後)	排尿障害なく 腎機能正常	○	15番 (2～5年) ～○	○	○	
			その他	×～割増	×	×～○	×	
	腎移植 (レシピエント)	腎移植を受けた場合		×	×	×	×	
	腎移植 (ドナー) 腎ドナー 生体腎提供者	残存腎の 腎機能正常の場合	治癒後:6ヶ月未満	×	×	○	×	【査定上のポイント】 診査および血液検査(もしくは腎機能検査結果を含む最近の健康診断結果)が必要です。
			治癒後:6ヶ月以上	○	○	○	○	
		その他		×	×	×	×	
	腎盂炎 腎盂腎炎	既往症 (発症1回)	治癒後:2年未満	○	15、16番 (2年)	○	○	【査定上のポイント】 複数回の発症がある場合は別途評価となります。(個別判断)
			治癒後:2年以上	○	○	○	○	
	腎硬化症	現症/既往症		×	×	×	×	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足	
				死亡	医療	ガン	特定疾病		
泌尿器	腎結石 尿管結石	現症 (現在結石あり)		○～割増	51 番※ (5 年)	○	○～×	※告知内容によっては、不担保部位が 15、16 番になる可能性があります。	
		既往症 (現在結石なし)	手術 1 回	○	51 番※ (2～5 年) ～○	○	○	【査定上のポイント】 疾患が両側の場合、片側のみの場合よりも査定は厳しくなります。その他、結石の数、発作の頻度、手術(体外衝撃波による治療を含む)回数により異なります。	
			手術 2 回以上						【告知のポイント】 結石は片側か両側か、これまでの手術回数、治療内容(薬剤名、体外衝撃波破碎術:ESWL等の手術内容)、腎機能障害等後遺症の有無
			治癒後:2 年未満	割増	51 番※ (5 年)	○	×		
			治癒後:2 年以上	○	51 番※ (2～5 年)	○	○		
	膀胱炎	現症※		×	×	×	×	※頻回発症、入院、合併症のいずれもない女性の場合は、現症でもお引受けの可能性があります。 【査定上のポイント】 慢性膀胱炎・間質性膀胱炎は別途判断となります。	
		既往症:治癒後		○	○	○	○		
	尿道炎	既往症:治癒後(かつ合併症なし)		○	○	○	○		
	過活動膀胱	現症(女性のみ)※		○	16 番 (2 年)	○	○	※男性の場合、個別判断となります。 【査定上のポイント】 ・若年発症、入院、手術歴や合併症がある場合、個別判断となります。	
		既往症	治癒後:2 年未満	○	16 番 (2 年)	○	○	【告知のポイント】 原因・治療内容(薬剤名)・治療期間・手術の有無・合併症の有無	
			治癒後:2 年以上	○	○	○	○		
	膀胱結石	現症		割増	51 番※ (5 年) 女疾:×	○	×	※告知内容によっては、不担保部位が 16 番になる可能性があります。	
		既往症	発作 1 回のみ	○	51 番※ (2～5 年) ～○	○	○		
			発作 2 回以上						
			最終発作から 2 年未満	割増	51 番※ (2～5 年) 女疾:×	○	×		
			最終発作から 2 年以上	○	○	○	○		

分類	傷病名	判断条件		目安				補足	
				死亡	医療	ガン	特定疾病		
泌尿器	急性前立腺炎	既往症	治癒後:2 年未満	○	18 番 (2 年)	○	○		
			治癒後:2 年以上	○	○				
	慢性前立腺炎	現症/既往症		○	18 番 (全期間)	○	○	【査定上のポイント】 尿所見に異常を認める場合等は別途評価となります。	
	前立腺肥大症	現症 かつ PSA 正常範囲内 (4.0ng/ml 以下)	診断後: 6 ヶ月未満	削減	18 番 (全期間)	×	×	※手術については、経尿道的前立腺切除術 (TUR-P) 以外の術式の場合(腹腔鏡や開腹 術など)、厳しい評価となります。 【査定上のポイント】 ・精密検査にて診断が確定している前提で す。 ・尿所見や腎機能・PSA 値等に異常が見られ る場合は個別判断となります。 ・診断書にて良性が明確であれば、診断後早 期でも緩和の可能性あります。 【告知のポイント】 検査内容と検査結果(PSA 値、超音波など)、 治療内容(薬剤名)、手術内容	
			診断後: 6 ヶ月以上	○	18 番 (全期間)	×～○	×～○		
		既往症 (術後含む※)	治癒後: 1 年未満	削減	18 番 (2～5 年)	×	×		
			治癒後: 1 年以上	○	○	○	○		
	精巣炎 睾丸炎 精巣上体炎	既往症:治癒後		○	○	○	○		
	陰嚢水腫 精巣水瘤 精索水瘤 精液瘤	現症		○	17 番 (5 年)	○	○		
		既往症	治癒後(穿刺のみ)						
			2 年未満	○	17 番 (2 年)	○	○		
			2 年以上	○	○	○	○		
		治癒後(手術後)		○	○	○	○		

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
泌尿器	腎膿瘍 腎周囲膿瘍	現症		×	×	×	×	【査定上のポイント】 基礎疾患および合併症・後遺症のない場合に 限ります。
		既往症	治癒後:3年未満	○	15、16番 (3年)	○	○	
			治癒後:3年以上	○	○	○	○	
	遊走腎 異所性腎 変位腎	現症	腎機能異常なし	○	15番 (2～5年)	○	○	【査定上のポイント】 ・診査または最近の健康診断結果が必要です。 ・腎機能異常がある場合は別途評価(厳しい 評価)となります。

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
精神疾患	うつ病 パニック障害 不安神経症 強迫性障害 恐怖性障害 心的外傷後ストレス障害(PTSD) 適応障害	診断後:1年未満		×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・診断書が必要です。入院有無含む病状経過・社会適応状況(就学・就労状況)・治療内容・コントロール状況等により個別に判断します。 ・診断からの経過が浅い場合には厳しい評価となります。
		診断後:1年以上		割増～×	×	○	×	
	ナルコレプシー (睡眠発作)	現症 既往症 (事故歴がない場合)		○	×	○	○	【査定上のポイント】 ・診断書が必要となる可能性があります。 ・受診経緯、経過期間、事故歴の有無、治療内容、コントロール状況、発作頻度(回/年)、最終発作時期、職種・職務の具体的内容等により、厳しい評価となる可能性があります。
	不眠症 睡眠薬常用	現症(入院歴なし)		割増	×	○	×	【査定上のポイント】 ・他の(精神)疾患との鑑別も重要になります。治療期間、治療内容(薬剤名)、入院有無等により判断します。 ・入院歴がある場合、薬剤名より他の疾患が疑われる場合は別途判断となります(左記とは異なります)。 ・診断書が必要になる場合があります(入院歴がある場合は必須)。 【告知のポイント】 治療開始時期、治療内容(薬剤名)、症状経過
		既往症(入院歴なし)		割増～○	割増～○	○	×～○	
	神経性食欲不振症 拒食症 過食症	現症		×	×	×	×	【査定上のポイント】 診断書が必要です。 治療後であっても、未成年者は厳しい評価となります。 体重減少・無月経症・うつ・アルコールや薬物等の乱用歴があればすべて×となります。
		既往症	治療後:1年未満	×	×	×	×	
			治療後:1年以上 2年未満	割増	×	○	×	
			治療後:2年以上	割増～○	×～割増	○	×～○	

分類	傷病名	判断条件	目安				補足
			死亡	医療	ガン	特定疾病	
精神疾患	慢性アルコール中毒 アルコール依存症	現症/既往症	×	×	×	×	
	統合失調症 双極性障害 (旧名:躁うつ病)	現症/既往症	×	×	×	×	
	ADHD (注意欠陥・多動性障害)	現症/既往症	割増～×	×	○～×	×	【査定上のポイント】 ・診断書が必要です。 ・原因・入院有無含む病状経過・社会適応状況(就学・就労状況)・治療内容・コントロール状況・合併症等により個別に判断します。 ・診断からの経過が浅い場合、もしくは、若年者(就業前)の場合には厳しい評価となります。

分類	傷病名	判断条件			目安				補足
					死亡	医療	ガン	特定疾病	
新生物	胆のうポリープ	現症※1※2	発見後:2年未満		削減 ※3 ～○	13 番 (2～3 年)	×	×	※1 精密検査指示にもかかわらず未精査の場合、追加の検査や治療予定がある場合は×
			発見後:2年以上		○	○	○	○	
		既往症※2	腹腔鏡手術	術後: 1年未満	削減	×	×	×	※2 診断書が必要となる場合があります。(既往症について、診断書にて内容良好と確認できる場合、緩和の可能性あります。)また、開腹手術の場合は個別判断となります。 ※3 定期健診における腹部エコー検査による指摘で、経過観察判定(1年以上の経過観察判定の場合のみ。1年後再検査を含む)と健診結果にて直接確認できる場合は○ 【査定上のポイント】 ・悪性所見があった場合は胆嚢癌で評価します。 【告知のポイント】 ・現症の場合⇒指摘時期と判定内容 ・既往症の場合⇒手術時期・術式・入院期間・術後の経過
				術後: 1年以上	○	○	○	○	
			開腹手術	術後: 6か月未満	×	×	×	×	
				術後: 6か月以上2年未満	削減	×	×	×	
				術後: 2年以上	○～削減	○～×	○～×	○～×	
	胃ポリープ 大腸ポリープ 直腸ポリープ	現症※1	発見後:2年未満		削減 ※2 ～○	該当 部位 (2～3 年)	×	×	※1 精密検査指示にもかかわらず未精査の場合はすべて×
			発見後:2年以上		○	○	○	○	
		既往症	内視鏡術後:2年未満 ※3		削減	該当 部位 (2～3 年)	×	×	※2 胃ポリープについては、定期健診における胃カメラ検査もしくはバリウム検査による指摘で、経過観察判定(1年以上の経過観察判定の場合のみ。1年後再検査を含む)と健診結果にて直接確認できる場合は○ ※3 診断書により緩和の可能性あります。 可。 【査定上のポイント】 ・悪性所見があった場合は胃癌/大腸癌で評価します。 【告知のポイント】 ・現症の場合⇒指摘時期と検査内容および判定内容 ・既往症の場合⇒手術時期・術式・入院期間・術後の経過
			内視鏡術後:2年以上		○	○	○	○	
			開腹術後(腹腔鏡術後も含みます)		悪性腫瘍 (胃癌・大腸癌) に準じる※3		×	×	
	声帯ポリープ	現症	手術予定がない場合		○	6 番 (2～3 年)	×	×	【査定上のポイント】 手術内容・入院期間等より他の疾患が疑われる場合は個別判断となります。 【告知のポイント】 発症時期・手術時期・手術内容・入院期間・完治時期
		既往症 (手術後)	治癒後:2年未満		○	6 番 (2～3 年)	○	○	
			治癒後:2年以上		○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足	
				死亡	医療	ガン	特定疾病		
新生物	子宮頸管ポリープ	現症	精査や手術の予定がない場合で医師の管理下にて経過観察中		○	20 番 (2～3 年)	○	○	※手術の内容等により個別判断となります。 【査定上のポイント】 手術内容・入院期間等より他の疾患が疑われる場合は別途評価となります。 【告知のポイント】 指摘の経緯・手術時期・手術内容・入院期間・完治時期
			上記以外		×	×	×	×	
		既往症 (手術済)	ポリープのみ外来で切除した場合	治癒後：6ヶ月未満	○	20 番 (2～3 年)	○	○	
				治癒後：6ヶ月以上	○	○	○	○	
			その他の手術 ※		×～○	×～○	×～○	×～○	
	子宮内膜ポリープ	現症 ※1	医師の管理下にて経過観察中	発見後：1年以内	削減	20 番 (3～5 年) 女疾×	×	×	※1精密検査や手術の予定がある場合はすべて× ※2 手術の内容等により個別判断となります。 【査定上のポイント】 ・手術内容・入院期間等より他の疾患が疑われる場合は別途評価となります。 【告知のポイント】 指摘の経緯・手術時期・手術内容・入院期間・完治時期
				発見後：1～5 年	○	20 番 (2～3 年)	×～○	×～○	
				発見後：5 年超	○	○	○	○	
			医師の管理下でない場合		削減	20 番 (3～5 年) 女疾×	×	×	
		既往症 (手術済)	ポリープのみを切除した場合	治癒後：1年以内	削減	20 番 (2～3 年) 女疾×	×	×	
				治癒後：1 年超	○	○	○	○	
			その他の手術 ※2		×～○	×～○	×～○	×～○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
新生物	子宮頸部異形成	未治療・経過観察中 (検査指摘のみ)	軽度異形成、中等度異形成、高度異形成、 (LSIL、HSIL、ASC-US、SCC、クラスⅢa、 クラスⅢb、クラスⅣ、 クラスⅤ、CIN1、CIN2、 CIN3 など)	×	×	×	×	※1 経過観察中の検査結果が正常範囲内、精査にて異常を認めない等の場合、検査内容と結果、経過年数、検査頻度等を総合的に判断し、条件付(もしくは○)での引受の可能性があります。 ※2 手術の内容等により個別判断となります。 【査定上のポイント】 ・過去分含む検査結果または/および診断書が必要となる場合があります。 【告知のポイント】 ・指摘の経緯と時期、指摘の内容(具体的な検査結果)、精密検査実施有無(精査内容・時期と精査結果)、治療歴(手術内容・入院期間含む)、定期検査の有無(検査内容と検査結果)および検査実施の頻度、今後の通院・治療予定など
			NILM、またはクラスⅠ、Ⅱ かつ、今までに一度でも上記の軽度異形成、中等度異形成、高度異形成の指摘がない場合	○	○	○	○	
		治療歴あり(手術後) ※2		×～○	×～○	×～○	×～○	
	脂肪腫 粉瘤 その他体表の良性腫瘍	現症	手術予定がない場合	○	37 番 (2 年)	○	○	【査定上のポイント】 手術内容・入院期間等より悪性疾患が疑われる場合は別途評価となります(診断書が必要です)。 【告知のポイント】 正式診断名・部位・大きさと数・手術時期・手術内容・入院期間・完治時期
		既往症	切除後かつ治癒後	○	○	○	○	
	下垂体腺腫	現症	(未切除の場合)	×	×	×	×	【査定上のポイント】 手術内容・入院期間等より悪性疾患が疑われる場合、術後継続的な治療がある場合、腫瘍残存がある場合等は別途評価となります(診断書が必要です)。 【告知のポイント】 指摘の経緯、具体的な症状と経過、手術内容・薬剤名含む治療内容、術後の経過(通院・検査・治療状況)、後遺症の有無
		既往症 (切除後)	治癒後:3 年未満	×	×	×	×	
			治癒後:3 年以上 (継続的な治療や経過観察もない場合)	○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
新生物	舌癌・咽頭癌・喉頭癌・食道癌・肺癌・肝臓癌・膵臓癌・胆嚢癌・胆管癌・胆道癌・悪性黒色腫(メラノーマ)・悪性リンパ腫・ホジキン病・非ホジキンリンパ腫・白血病・肉腫・骨肉腫	既往症	治療終了後:7年未満	×	×	×	×	・原則として診断書(ステージ等詳細情報)による判断となります。(個別判断) ・削減と記載がある部分は削減+割増(もしくは割増)となる場合があります。 ・下記の場合は厳しい評価となります。 ・50歳未満 ・リンパ節転移あり ・開腹手術(等侵襲度の高い手術) ・下記の場合は原則的に×となります。 ・遠隔転移あり ・再発あり ・複数の癌既往あり ・上皮内癌等の早期癌で治療終了後の経過も良好な場合、左記より緩和となる可能性があります(診断書必須)。 ・診断書には以下の情報が必要です。 ①診断名 ②治療期間(入退院日含む) ③手術日および手術内容(手術方法・手術名含む) ④病理所見(病理診断名、ステージ、グレード、TNM分類など) ⑤術後の治療内容(放射線療法、化学療法を含む)およびその期間 ⑥直近の検査結果 ⑦その他腫瘍の種類により必要となる分類等
			治療終了後:7年以上10年未満	×～削減	×	×	×	
			治療終了後:10年以上	×～○	×～○	×	×	
	胃癌・大腸癌・直腸癌・結腸癌・S状結腸癌・肛門癌・膀胱癌・陰茎癌・悪性睾丸腫瘍・腎臓癌・乳癌・卵巣癌・子宮癌・子宮体癌・子宮頸癌	既往症	治療終了後:5年未満	×	×	×	×	
			治療終了後:5年以上7年未満	削減～×	×	×	×	
			治療終了後:7年以上	○～×	○～×	×	×	
	甲状腺癌・前立腺癌・皮膚癌(悪性黒色腫を除く)	既往症	治療終了後:3年未満	×	×	×	×	
			治療終了後:3年以上5年未満	削減～×	×	×	×	
			治療終了後:5年以上	○～×	○～×	×	×	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
新生物	甲状腺腫 甲状腺腫大(手術を要しないもの)	原因が判明しないもの (未精査を含む)		×	×	×	×	※原則として、診断書が必要です。(個別判断) 【査定上のポイント】 ・不明点が残る場合は厳しい評価となります。 【告知のポイント】 正式診断名・原因・発症時期・大きさ・実施した検査内容と検査結果・具体的な症状および経過・現在までの治療歴(薬剤名含む)・合併症
		単純性(びまん性)甲状腺腫 (甲状腺機能正常の場合に限る)※		○	5 番 (5 年)	○	○	
		上記以外(結節性甲状腺腫を含む)※		×～○	×～5 番 (5 年 or 全期間)	×～○	×～○	
	髄膜腫 聴神経腫瘍	既往症	完全切除・再発無 (切除後 6 か月以上)	○	○	○	○	【査定上のポイント】 ・良性和診断されているものに限りま ・診断書が必要となる場合があります ・後遺症がある場合は別途評価となります 【告知のポイント】 ・正式診断名、手術内容、術後経過(通院頻度・検査結果含む)、後遺症(あればその詳細)
	膀胱ポリープ	現症		×	×	×	×	【査定上のポイント】 既往症については、診断書の内容により個別判断となります。
		既往症	切除後かつ治癒後	○～×	○～×	○～×	○～×	
	縦隔腫瘍	現症		×	×	×	×	【査定上のポイント】 既往症については、診断書の内容により個別判断となります。
		既往症	切除後かつ治癒後	○～×	○～×	○～×	○～×	
	骨腫瘍(良性のもの)	現症	(未切除の場合)	×	×	×	×	【査定上のポイント】 手術内容・入院期間等より悪性疾患が疑われる場合は別途評価となります(診断書が必要です)。 【告知のポイント】 正式診断名・部位・大きさと数・手術時期・手術内容・入院期間・完治時期・後遺症有無
		既往症 (切除後)	治癒後:2 年未満	×	×	×	×	
			治癒後:2 年以上 4 年未満	削減	該当部位 (2～5 年) ～×	×	×	
			治癒後:4 年以上	○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件	目安				補足
			死亡	医療	ガン	特定疾病	
血液・造血器	血液検査結果						※告知内容・その他血液所見・数値推移等を考慮し、個別判断となります。
	血色素量 ヘモグロビン (Hb)	男性: 9g/dl 未満 女性: 8g/dl 未満	×	×	×	×	【査定上のポイント】 通院・治療中等の場合は個別判断となります。
		男性: 13～18g/dl 女性: 12～16g/dl	○	○	○	○	
	白血球数 (WBC)	2,500/ μ L 未満	×	×	×	×	
		2,500～3,000/ μ L 未満※	割増 or 削減～×	×	×～○	×	
		3,000～12,000/ μ L 未満	○	○	○	○	
		12,000～15,000/ μ L 未満※	割増 or 削減～×	×	×～○	×	
		15,000/ μ L 以上	×	×	×	×	
	血小板数 (PLT)	～10 万/ μ L 未満	×	×	×	×	
		10 万～13 万/ μ L 未満※	割増～×	×	×～○	×	
		13 万～45 万/ μ L 未満	○	○	○	○	
		45 万～60 万/ μ L 未満※	割増～×	×	×～○	×	
		60 万/ μ L～	×	×	×	×	
	鉄欠乏性貧血 (原因不明の場合)	男性 Hb 13g/dl～ 女性 Hb 10g/dl～	○	○	○	○	【査定上のポイント】 ・貧血の原因が判明している場合は、別途原因の評価が加わります。 ・急激に悪化している場合や症状を伴う場合等は別途評価となります。 ・血液検査結果(赤血球数・ヘモグロビン値・ヘマトクリット)が査定には必須です。 【告知のポイント】 指摘経緯および時期・具合的症状・治療内容(薬剤名含む)・経過
		閉経前の女性 Hb 8～10g/dl	割増～○	割増 女疾: ×	○	×～○	
	巨赤芽球性貧血 (悪性貧血)	現症/既往症	○～×	○～×	○～×	○～×	【査定上のポイント】 ・原則として、診査＋血液検査が必要です。追加で、健診結果(血液検査結果を含むもの)や診断書が必要となる場合があります。(個別判断) ・原因・治療歴・数値等による評価となります。 ・ビタミン補充療法で改善している場合は○の可能性あります。
	真性多血症 真性赤血球増加症	現症/既往症	×	×	×	×	
	再生不良性貧血	現症/既往症	×	×	×	×	
	溶血性貧血	現症/既往症	○～×	○～×	○～×	○～×	【査定上のポイント】 ・原則として、診査＋血液検査が必要です。追加で、健診結果(血液検査結果を含むもの)や診断書が必要となる場合があります。(個別判断) ・原因・治療内容詳細・数値等による評価となります(診断書が必要となる場合があります)。

分類	傷病名	判断条件		目安				補足	
				死亡	医療	ガン	特定疾病		
血液・造血器	ヘノッホ・シェーンライ ン紫斑病 アレルギー性紫斑病 IgA 血管炎	現症		×	×	○	×	【査定上のポイント】 原則として、診断書または健診結果(尿・腎機能 検査を含むもの)が必要です。 【告知のポイント】 治療期間・治療内容(薬剤名含む)・合併症およ び後遺症の有無	
		既往症	治癒後:6 か月未満 (合併症・後遺症無)	×	×	○	×		
			治癒後:6 か月以上 (合併症・後遺症無)	○	○	○	○		
			腎障害等の合併症 ・後遺症あり	×	×	×	×		
	特発性血小板減少性 紫斑病(ITP)	現症	治療中	×～割増	×	○	×	※既往症の場合は原則として個別判断となります。 【査定上のポイント】 ・最近の血小板数の確認が必要です。 ・原因が判明している場合は原因による評価と なります。 【告知のポイント】 ・治療期間・治療内容(薬剤名含む)・手術有無 についての告知が必要です。	
		既往症 ※	無治療で2年以上経過	×～○	×	○	×～○		
			脾臓摘出術あり						
			治癒後:6 か月未満	×	×	×	×		
			治癒後:6 か月以上 (血小板数により評 価)	○～×	割増× 女疾:×	○～×	○～×		
		後天性免疫不全症候 群(HIV)	現症/既往症	×	×	×	×		

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
感染症	風邪 インフルエンザ はしか 流行性耳下腺炎 おたふく風邪 百日咳	治癒後(かつ後遺症なし)		○	○	○	○	【査定上のポイント】 入院歴や合併症・後遺症がある場合は、 個別判断となります。
	風疹	治癒後:1ヶ月未満		×	×	×	×	
		治癒後:1ヶ月以上(かつ後遺症なし)		○	○	○	○	
	結核(肺)	現症		×	×	×	×	【査定上のポイント】 肺以外の臓器に病変が及んでいる場合、 合併症・後遺症がある場合は個別判断と なります。
		既往症	治癒後:1年未満	割増	割増	○	×	
			治癒後:1年以上	○	○		○	
	淋病 クラミジア	既往症	治癒後:1ヶ月未満	×	×	×	×	【査定上のポイント】 後遺症がない場合に限ります。
			治癒後:1ヶ月以上	○	○	○	○	
	川崎病	既往症	治癒後:1年未満	×	×	×	×	※冠動脈瘤等の後遺症がない場合に限り ます。 【査定上のポイント】 発症時期・治療内容・治療経過・後遺症有 無等を確認する為、診断書の提出が必要 となります。
			治癒後:1年以上 3年未満 ※	○	×	○	×	
			治癒後:3年以上 ※	○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
妊娠・分娩	妊娠中 正常分娩 吸引分娩※1 鉗子分娩※1	妊娠中～ 正常分娩後1ヵ月以内※2		○	47 番 (1 年)	○	○	※1 吸引分娩・鉗子分娩について、その他の異常がない場合は正常分娩(左記評価)として評価します。 ※2 妊娠8ヵ月～正常分娩後1ヵ月以内の場合は、マニフレックス・マニユメッドの『重度疾病保障特約』、こだわり医療保険 with PRIDE の『七大生活習慣病入院特約』は×となります。 【査定上のポイント】 妊娠経過に何らかの異常がある場合、異常妊娠・異常分娩の既往歴がある場合は個別判断となります。
		正常分娩後1ヵ月経過後		○	○	○	○	
	子宮外妊娠 人工中絶 死産	既往症	治癒後:1ヵ月未満	○	×	○	×	
			治癒後:1ヵ月以上 3ヶ月未満	○	20 番 (2～5 年)	○	○	
			治癒後:3ヶ月以上	○	○	○	○	
	悪阻(入院歴あり) 切迫流産 切迫早産	現症※1	妊娠中 (入院中は除く)	○	×	○	×	※1 症状消失後安定しており、入院予定や手術予定がないものに限る。(基礎疾患や合併症がある場合は×) ※2 現在妊娠中の場合は 20 番(2～5 年)となります。
		既往症	分娩後:1ヵ月未満	○	×	○	×	
			分娩後:1ヵ月以上 3年未満	○	20 番 (2～5 年)	○	○	
			分娩後:3年以上	○	○※2	○	○	
	流産 早産 前置胎盤 胎盤早期剥離 帝王切開 ※1	既往症	分娩後:1ヵ月未満	○	×	○	×	※1 帝王切開の場合、帝王切開の原因が児頭骨盤不適合・前回帝王切開・逆子と判明した場合は 34 番(2～5 年)となります。 ※2 現在妊娠中の場合は 20 番(2～5 年)となります。 【告知のポイント】 (帝王切開の場合)帝王切開を行った理由(分かれば)
			分娩後:1ヵ月以上 3年未満	○	20 番 (2～5 年) ※1	○	○	
			分娩後:3年以上	○	○※2	○	○	
	習慣性流産 頸管無力症 子宮頸管無力症	現症 ※1		○	×	○	×	※1 症状消失後安定しており、入院予定や手術予定がないものに限る。(基礎疾患や合併症がある場合は×) ※2 現在妊娠中の場合は 20 番(2～5 年)となります。
		既往症	治癒後:1ヵ月未満	○	×	○	×	
			治癒後:1ヵ月以上 3年未満	○	20 番 (5 年)	○	○	
			治癒後:3年以上	○	○※2	○	○	
	妊娠中毒症 妊娠高血圧症候群 子癇	既往症	治癒後:1ヵ月未満	×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・原則として、診査、もしくは、健診結果が必要です。 ・現在、高血圧・蛋白尿等の異常がない前提です(異常がある場合は個別判断)
			治癒後:1ヵ月以上 3年未満	○	20 番 (2～5 年)	○	○	
			治癒後:3年以上	○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
妊娠・分娩	胞状奇胎	既往症	治癒後:1 年未満	×	×	×	×	【査定上のポイント】 治療内容(手術内容)・経過(hCG 値推移)等により、診断書が必要となる場合があります。 【告知のポイント】 治療歴(手術内容含む)・hCG 値推移含む経過、侵入奇胎等の指摘の有無も分かれば、よりの確な査定が可能です。
			治癒後:1 年以上 2 年未満	削減	×	×	×	
			治癒後:2 年以上	○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
婦人科	不正出血	現症	精査にて器質的な異常を認めない場合	○	20、21 番 (2～5 年)	○	○	【査定上のポイント】 ・原因が判明している場合は原因疾患によりま す。 ・未精査の場合は左記とは異なります。 【告知のポイント】 原因(判明している場合)、実施した検査内容と 検査結果、治療内容(薬剤名等)、症状経過
		既往症	精査にて器質的な異常を認めない場合	○	20、21 番 (2～5 年) ～○	○	○	
	高プロラクチン血症	現症 (投薬によりコントロール良好な場 合)		割増～○	×	○～×	×～○	【査定上のポイント】 ・原則として、診断書が必要です。 ・原因(腺腫、薬剤等)、治療内容(薬剤名含 む)、入院期間、手術の有無、投薬治療によるコ ントロール状況、合併症等について確認が必要 です。
		手術なし	治療後: 2年未満	○	×	○～×	○	
			治療後: 2年以上	○	○	○	○	
		手術あり	治療後: 1年未満	○	×	○～×	○	
			治療後: 1年以上	○	○	○～×	○	
		既往症						
	月経異常 (無月経・過多月経・月 経困難・生理不順・ PMS)	現症	精査にて器質 的な異常を認 めない場合	○	20、21 番 (2～5 年)	○	○	【査定上のポイント】 ・原因が判明している場合は原因疾患によりま す。 ・未精査の場合は左記とは異なります。 【告知のポイント】 原因(判明している場合)、実施した検査内容と 検査結果、治療内容(薬剤名等)、症状経過
		既往症	精査にて器質 的な異常を認 めない場合	○	20、21 番 (2～5 年) ～○	○	○	
	更年期障害	現症		○	割増 女疾:×	○	○	【査定上のポイント】 精神・神経症状等がある場合は別途判断となり ます。 【告知のポイント】 治療内容(薬剤名)、症状経過、合併症
		既往症	治療後:1年未 満		○			
	子宮脱	現症		○	20 番 (全期間)	○	○	
		既往症 (手術後)	治療後:2年未 満		20 番 (2 年)			
			治療後:2 年 以上		○			

分類	傷病名	判断条件			目安				補足	
					死亡	医療	ガン	特定疾病		
婦人科	子宮筋腫	現症	発見後 1 年未満		削減	20 番 (3～5 年) 女疾: ×	×	×	※診断書が必要となる場合があります。(診断書にて内容良好と確認できる場合、緩和の可能性がありますが) 【査定上のポイント】 ・入院期間、手術の有無(および手術の内容)、治療内容等により判断します。 ・入院が長期(1 ヶ月以上等)の場合、術式等より別の疾患や合併症が疑われる場合は別途評価となります(厳しい評価になります)。	
			発見後 1 年以上かつ (医師の管理下にて) 経過観察中		○	20 or 48 番 (2～5 年)	○	○		
			発見後 1 年以上だが 医師の管理下でない場合		削減	20 番 (3～5 年) 女疾: ×	×	×		
		既往症 (手術後)※	治癒後:6 ヶ月未満		×	×	×	×		
			治癒後:6 ヶ月以上 1 年未満		削減	×	×	×		
			治癒後:1 年以上		○	○	○	○		
	子宮内膜症 子宮腺筋症 チョコレート嚢胞	既往症	現症			○	49 番※ (全期間)	○	○	※子宮腺筋症、チョコレート嚢胞の場合、および、告知内容によっては不担保が 20、21 番になります。 【告知のポイント】 部位、手術内容・薬剤名を含む治療歴、合併症
			治癒後:2 年未満			○	49 番※ (2 年)	○	○	
			治癒後:2 年以上			○	○	○	○	
	子宮内膜増殖症 子宮内膜異型増殖症	既往症	現症			×～○	×～20 番 (2 年)	×～○	×～○	【査定上のポイント】 ・原則として診断書が必要になります。(個別判断)
			子宮 全摘出術済	手術後: 1 年未満	×	×	×	×		
				手術後: 1 年以上	○	○	○	○		
				・子宮全摘出術以外の手術 ・手術未実施など		×～○	×～○	×～○	×～○	
	多嚢胞性卵巣症候群	現症/既往症			○	20、21 番 (5 年)	○	○	【査定上のポイント】 健診結果(体格・血圧・血中脂質検査を含むもの)が必要となる場合があります。 ・上記の健診異常、原因疾患、または、合併症がある場合等は別途評価になります。(引受不可の可能性もあります。) 【告知のポイント】 原因、治療内容(薬剤名)、合併症の有無	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
婦人科	卵巣のう腫	現症	発見後1年未満	削減	21番 (3～5年) 女疾:×	×	×	※診断書が必要となる場合があります(診断書にて内容良好と確認できる場合、緩和の可能性あります) 【査定上のポイント】 ・入院期間、手術の有無(および手術の内容)、治療内容等により判断します。 ・入院が長期(1ヵ月以上等)の場合、術式等より別の疾患や合併症が疑われる場合は別途評価となります(厳しい評価になります)。
			発見後1年以上かつ(医師の管理下にて)経過観察中	○	21番 (3～5年)	○	○	
			発見後1年以上だが医師の管理下でない場合	削減	21番 (3～5年) 女疾:×	×	×	
		既往症 (手術後)※	治癒後:6ヵ月未満	×	×	×	×	
			治癒後:6ヶ月以上1年未満	削減	×	×	×	
			治癒後:1年以上	○	○	○	○	
	卵巣腫瘍 (卵巣のう腫と診断されている場合は「卵巣のう腫」、悪性の場合は「卵巣癌」を参照)	現症		×	×	×	×	原則として診断書による判断となります。 手術後で、診断書にて内容良好と確認できる場合、緩和の可能性あります。(個別判断) 【査定上のポイント】 入院期間、手術の内容、治療内容等により判断します。 【告知のポイント】 正式診断名・手術時期・手術内容・入院期間・完治時期・後遺症有無
		既往症 (手術後)		×～○	×～○	×～○	×～○	
	乳腺炎	現症		○	19番(2年)	○	○	
		治癒後		○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
婦人科	乳腺症 乳房腺腫 乳腺線維腺腫 乳腺石灰化 乳腺嚢胞 乳管拡張症 乳管内乳頭腫 (健康診断・乳癌 検診指摘を含む)	現症	精密検査指示 にもかかわらず未精査	×	×	×	×	※1 経過観察判定の場合 (1 年以上の経過観察判定の場合のみ。1 年後再検査を含む) 上記以外は個別判断 ※2 判定内容を検査結果にて直接確認で きる場合、緩和の可能性があります。 ※3 診断書により緩和の可能性があります。 【査定上のポイント】 ・術式を含む治療内容によっては、評価が 左記と異なる可能性があります。 ・健康診断・乳癌検診指摘の場合は、原則として、検査結果が必要です。 ・診断書が必要となる場合があります。
			発見後:1 年未満 ※1※2	削減	19 番 (3~5 年) 女疾:×	×	×	
			発見後:1 年以上 2 年未満 ※1※2	○	19 番 (2~3 年)	×	×	
			発見後:2 年以上 ※1	○	○	○	○	
		既往症 (手術後) ※3	治癒後:6 ヶ月未満	×	×	×	×	
			治癒後:6 ヶ月以上 1 年未満	削減	×~19 番 (2~3 年) 女疾:×	×	×	
			治癒後:1 年以上	○	○	○	○	
	不妊症(女性)	現症		○	20、21 番 (3 年)	○	○	【査定上のポイント】 原因疾患のあるものは個別判断となります。
		既往症	治癒後 ~45 歳	○	20、21 番 (3 年)	○	○	
			治癒後 46 歳~	○	○	○	○	
	不妊症(男性)	現症		○	17 番 (3 年)	○	○	【査定上のポイント】 原因疾患のあるものは個別判断となります。

分類	傷病名	判断条件	目安				補足
			死亡	医療	ガン	特定疾病	
皮膚	带状疱疹	現症※	○	×	○	○	※症状が安定しており、入院がない場合 【査定上のポイント】
		既往症	○	○	○	○	入院歴、合併症・後遺症がある場合や基礎疾患がある場合には個別判断となります。
	アトピー性皮膚炎	現症	○	40 番 (5 年) ※1.2.3	○	○	※1 重症の場合は医療×になります。 ※2 顔面に及んでいる場合は1 番も不担保となります。 ※3 告知内容によっては、不担保部位が39 番になる可能性があります。 【告知のポイント】
		既往症	○	○	○	○	治療内容(薬剤名含む)、症状のある部位(範囲)、治療経過、合併症(白内障・網膜剥離・気管支喘息などの有無)
	じんましん	現症	○	39 番 (5 年)	○	○	【査定上のポイント】 基礎疾患がある場合や、治療期間が長期(1 ヶ月以上)にもかかわらず未精査の場合は個別判断となります。
		既往症	○	○	○	○	
	(尋常性)乾癬	現症/既往症	○	39 番 (5 年)	○	○	【査定上のポイント】 ・尋常性乾癬以外の乾癬、関節炎を伴う場合、合併症を伴う場合、重症の場合は個別判断となります。 【告知のポイント】 治療内容(薬剤名含む)、皮膚症状のある部位(範囲)、関節症状の有無、合併症の有無
	湿疹	現症	○	○～ 40 番※ (5 年)	○	○	※告知内容によっては、不担保部位が39 番になる可能性があります。 【告知のポイント】
		既往症	○	○	○	○	治療内容(薬剤名含む)、皮膚症状のある部位(範囲)
	火傷、熱傷	現症	×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・瘢痕がある場合、合併症がある場合は個別判断になります。 【告知のポイント】
		既往症	○	○	○	○	受傷部位、治療内容、瘢痕や合併症の有無

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
皮膚	蜂窩織炎 蜂巣炎 フレグモーネ	現症		×	×	○	×	※左記以外は個別判断となります。 【告知のポイント】 原因、部位、治療期間、治療内容(薬剤名含む)、入院・手術・再発・基礎疾患の有無、合併症など
		既往症	入院・手術・再発・基礎疾患 いずれもなし かつ 治療期間が1ヶ月未満 ※	○	○	○	○	
	水虫 白癬	現在/既往症		○	○	○	○	
	掌蹠膿疱症	現症		○	39 番 (5 年)	○	○	【査定上のポイント】 関節症状や合併症を伴う場合、入院歴がある場合、また治療内容等により個別判断となります。(厳しい評価になります)
		既往症	治癒後:2 年未満	○	39 番 (2 年)	○	○	
			治癒後:2 年以上	○	○	○	○	
	手足口病	治癒後(かつ後遺症なし)		○	○	○	○	【査定上のポイント】 入院歴や合併症・後遺症がある場合は、個別判断となります。
	膿痂疹(のうかしん)とびひ	現症/既往症		○	○	○	○	【査定上のポイント】 頻回の発症、入院歴、合併症、基礎疾患等がある場合は個別判断となります。

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
骨の疾患	骨粗しょう症 (疑いを含む)	骨折の既往なし (股関節又は脊椎の骨折※)		○	割増～× 女疾:×	○	○	※股関節・脊椎以外の骨折でも、骨粗しょう症が原因と思われる場合は骨折の既往ありでの評価となります。 【査定上のポイント】 ・原因疾患がある場合は、原因疾患による評価も加わります。 【告知のポイント】 骨折歴の有無(有の場合、時期・部位・入院期間/手術内容含む治療歴)、治療内容(薬剤名含む)、合併症・後遺症の有無、原因疾患の有無とその詳細(特にステロイド治療を原因とする場合)
		骨折の既往あり (股関節又は脊椎の骨折※)	1回のみ 完治後	○～割増	×	○	○～×	
			2回以上 完治後	割増～×	×	○	×	
		ステロイド治療を原因とする骨粗しょう症		割増～×	×	○～×	×	
	脊柱管狭窄症 椎間板ヘルニア(頸椎・胸椎・腰椎) 脊椎椎間板症	現症	日常生活に支障なく、手術予定もない場合	○	該当部位 (全期間)	○	○	【査定上のポイント】 運動障害等がある場合は個別判断となります。 【告知のポイント】 部位(頸椎・胸椎・腰椎)、手術済のケースは術後の後遺症有無(有の場合その詳細まで)
		既往症	治癒後:2年未満	○	該当部位 (5年)	○	○	
			治癒後:2年以上	○	○	○	○	
	脊椎すべり症 脊椎分離症	現症	日常生活に支障なく、手術予定もない場合	○	該当部位 (5年 or 全期間)	○	○	
		既往症	治癒後:2年未満	○	該当部位 (2～5年)	○	○	
			治癒後:2年以上	○	○	○	○	
	変形性脊椎症 後縦靱帯骨化症	現症	日常生活に支障なく、手術予定もない場合	○	該当部位 (全期間)	○	○	
		既往症	治癒後:5年未満	○	該当部位 (5年)	○	○	
			治癒後:5年以上	○	○	○	○	
	脊柱側弯症 脊柱後弯症	現症	軽度の変形で日常生活に支障なく、手術予定もない場合	○	○～ 22 or 23 or 24 番 (2～5年)	○	○	左記以外は個別判断になります。 診査や診断書による確認が必要となる場合があります。
	変形性膝関節症	現症	日常生活に支障なく、手術予定もない場合	○	32 or 33 番 (5年 or 全期間)	○	○	※人工関節に置換されている場合、不担保になります。 【査定上のポイント】 運動障害等がある場合は、個別判断となります。 【告知のポイント】 部位(左右の別)、機能障害の有無(程度)
		既往症	治癒後:2年未満	○	32 or 33 番 (2～5年)	○	○	
			治癒後:2年以上	○	○※	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
骨の疾患	急性骨髄炎 急性骨膜炎	現症		×	×	○	×	
		既往症	治癒後:6ヶ月未満	×	×	○	×	
			治癒後:6ヶ月以上	○	○	○	○	
	慢性骨髄炎 慢性骨膜炎	寛解後:1年未満		×	×	○	×	【査定上のポイント】 重症度・治療歴等の確認のため、原則として 診断書が必要です。 【告知のポイント】 部位、治療歴、経過
		寛解後:1年以上		割増	割増+ 該当部位 (全期間)	○	×	
	肩関節周囲炎 (四十肩・五十肩)	現症		○	26 or 27 番 (5年)	○	○	【告知のポイント】 部位(左右の別)、治療歴、経過
		既往症	治癒後:2年未満	○	26 or 27 番 (2年)	○	○	
			治癒後:2年以上	○	○	○	○	
	ガングリオン	現症(未手術)		○	該当部位 (5年)	○	○	【告知のポイント】 部位(左右の別を含む)、治療歴(手術有 無)、経過
		治癒後(手術後)		○	○	○	○	
	顎関節症	現症		○	割増	○	○	
		既往症	治癒後:1年未満	○	割増	○	○	
			治癒後:1年以上	○	○	○	○	
	手根管症候群 腱鞘炎	現症		○	30 or 31 番 (5年)	○	○	【告知のポイント】 部位(左右の別)、治療歴、経過
		既往症	治癒後:2年未満	○	30 or 31 番 (2年)	○	○	
			治癒後:2年以上	○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
膠原病と筋の異常	慢性関節リウマチ	現症/既往症		割増 ※	×～割増 女疾: ×	○	×	※重症と判断されるケースは×の可能性が あります。 【査定上のポイント】 ・病変の範囲、関節変形の有無と程度、合併 症の有無により個別に判断します。 ・診断書が必要になる場合があります。 【告知のポイント】 治療内容(薬剤名、手術の有無など)、具 体的な症状(症状のある部位・関節変形の有無 および程度)、合併症の有無
	膠原病	現症/既往症		-	-	-	-	【査定上のポイント】 膠原病には多くの種類があり、それぞれ評価 が異なるため、正式な診断名が必要です。診 断書による確認が必要となる場合があります。
	全身性強皮症	現症/既往症		×	×	×	×	
	筋ジストロフィー	現症/既往症		×	×	×	×	
	多発性筋炎 リウマチ性多発筋痛 症 全身性エリテマトーデ ス(SLE) 結節性動脈周囲炎 ウェゲナー肉芽腫 重症筋無力症 限局性強皮症(皮膚 病変のみ)	現症/既往症	診断後: 2 年未満	×	×	×～○	×	【査定上のポイント】 ・診断書の提出が必要です。(個別判断) ・内臓合併症(腎臓・心臓等)、悪性腫瘍の合 併がある場合は全て×となります。 【告知のポイント】 発症時期、具体的症状および経過、治療内 容(薬剤名・手術内容含む)、内臓合併症有 無
			診断後: 2 年以上 5 年未満	割増～×	×	×～○	×	
			診断後: 5 年以上	割増～○	×～割増 女疾: ×	○～×	×～○	
	ベーチェット症候群	現症/既往症	診断後: 3 年未満	×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・診断書の提出が必要です。(個別判断) ・病変が中枢神経または眼に及ぶ場合、死 亡・医療いづれも×となります。
			診断後: 3 年以上 5 年未満	割増	割増～×	○	×	
			診断後: 5 年以上	割増～○	割増～○ 女疾: ×～○	○	×～○	
	シェーグレン症候群	現症/既往症		○～×	○～×	○	○～×	【査定上のポイント】 具体的な症状(範囲)、治療内容(薬剤名)、 合併症の内容により個別に判断します。診断 書が必要になる場合があります。(個別判断)

分類	傷病名	判断条件		目安				補足	
				死亡	医療	ガン	特定疾病		
外傷	頭部打撲 脳震盪	現症		×	×	×	×	【査定上のポイント】 ・加入時点で症状や後遺症がないことが前提です。 ・後遺症（麻痺・てんかん等）がある場合は個別判断となります。 【告知のポイント】 原因、受傷時の意識障害の有無、入院有無および入院期間、治療内容、後遺症の有無（ある場合その詳細）	
		既往症	入院なし	治癒後:3ヶ月未満	割増	36番 (2～5年)	○		×
				治癒後:3ヶ月以上	○	○	○		○
			入院あり	治癒後:1年未満	割増～○	36番 (2～5年) ～○	○		×～○
		治癒後:1年以上		○	○	○	○		
	頭蓋骨骨折	現症		×	×	○	×	【査定上のポイント】 ・加入時点で症状や後遺症がないことが前提です。 ・後遺症（麻痺・てんかん等）がある場合は個別判断となります。 【告知のポイント】 原因、受傷時の意識障害の有無、入院有無および入院期間、治療内容、後遺症の有無（ある場合その詳細）	
		既往症	治癒後:6ヶ月未満	×	×	○	×		
			治癒後:6ヶ月以上 2年未満	割増	割増～×	○	×		
			治癒後:2年以上	○	○	○	○		
	急性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫	現症		×	×	○	×		
		既往症	治癒後:6ヶ月未満	×	×	○	×		
			治癒後:6ヶ月以上	○	○	○	○		
	脳挫傷 外傷性くも膜下出血	現症		×	×	○	×		
		既往症	治癒後:6ヶ月未満	×	×	○	×		
			治癒後:6ヶ月以上 2年未満	割増	割増	○	×		
			治癒後:2年以上	○	○	○	○		
	脊椎骨折 (頸椎骨折を除く)	現症	部位や程度による	○～× ※	×	○	○～× ※	※原則として個別判断となります。 【査定上のポイント】 ・高齢者(65歳以上)の脊椎圧迫骨折は厳しい評価になります。 ・神経症状(後遺症)がある場合は個別判断になります。 【告知のポイント】 骨折部位(頸椎・胸椎・腰椎)・後遺症(神経症状)の有無	
		既往症	治癒後:1年未満	○	該当部位 (2年)	○	○		
			治癒後:1年以上	○	○	○	○		
	肋骨骨折 鎖骨骨折	現症		○	×	○	○	【査定上のポイント】 ・後遺症がある場合は個別判断になります。	
		既往症	治癒後:1年未満	○	36番 (2年)	○	○		
			治癒後:1年以上	○	○	○	○		

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
外傷	上肢・下肢の骨折 (大腿骨・膝関節部・ 大腿骨頸部および股 関節以外)	現症		○	該当部位 (5年)	○	○	※告知内容によっては、不担保部位が 36 番 になる可能性があります。 【査定上のポイント】 ・後遺症がある場合は個別判断になります。 ・(受傷時)65 歳以上の骨折の場合は左記より 厳しい評価になります。 【告知のポイント】 部位(左右の別含む)・金属等の内固定具の 有無(除去済か否かを含む)・後遺症(運動障 害・しびれ・変形等)の有無(有りの場合その 詳細)
		既往症	治癒後:6ヶ月未満	○	該当部位 (3年)	○	○	
			治癒後: 6ヶ月以上	○	41 番※ (2年)	○	○	
				○	○	○	○	
			治癒後:5年以上	○	○	○	○	
	大腿骨、膝関節部、大 腿骨頸部および股関 節の骨折	現症		○	×	○	○	※1 告知内容によっては、不担保部位が該 当部位になる可能性があります。 ※2 人工関節置換術をされている場合は、治 癒後期間にかかわらず医療保険には不担保 がつきます。 【査定上のポイント】 ・後遺症がある場合は個別判断になります。 ・65 歳以上の大腿骨頸部および股関節の骨 折の場合は左記より厳しい評価になります。 【告知のポイント】 部位(左右の別含む)・金属等の内固定具の 有無(除去済か否かを含む)・人工関節置換の 有無・後遺症の有無(有りの場合その詳細含 む)
		既往症	治癒後 :5年未満	○	41 番 ※1 (5年)	○	○	
				○	該当部位 (3年)	○	○	
			治癒後:5年以上	○	○ (不担保 ※2)	○	○	
	頸椎捻挫 (むち打ち症)	現症		○	×	○	○	【査定上のポイント】 複数回の既往がある場合、長期入院歴があ る場合等は厳しい評価となります。
		既往症	治癒後:1年未満	○	22 番 (2~5年)	○	○	
			治癒後:1年以上	○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
外傷	腰椎捻挫 (ぎっくり腰)	現症		○	×	○	○	
		既往症	治癒後:1年未満	○	24、25番 (2～5年)	○	○	
			治癒後:1年以上	○	○	○	○	
	靱帯損傷 (膝関節を除く)	現症		○	該当部位 (2年)	○	○	【告知のポイント】 部位(左右の別)、治療内容(手術の有無含む)・後遺症の有無(有りの場合その詳細)
		既往症	治癒後	○	○	○	○	
	半月板損傷 膝関節の靱帯損傷	現症		○	×	○	○	【告知のポイント】 部位(左右の別)、治療内容(手術の有無含む)・後遺症の有無(有りの場合その詳細)
		既往症	治癒後:5年未満	○	32 or 33番 (5年)	○	○	
			治癒後:5年以上	○	○	○	○	
	腰痛 坐骨神経痛	現症 ※1		○	24、25番 (5年)	○	○	※1 発症後 6 か月以内かつ整形外科で精査されていない場合は厳しい評価となります(全て×となる可能性)。 【査定上のポイント】 整形外科にて精査済であることが前提です。 【告知のポイント】 発症時期、実施した検査内容と検査結果、治療内容と期間、薬剤名
		既往症	治癒後:2年未満	○	24、25番 (3～5年)	○	○	
			治癒後:2年以上	○	○	○	○	

分類	傷病名	判断条件		目安				補足
				死亡	医療	ガン	特定疾病	
外傷	四肢の脱臼	現症		○	該当部位 (2～5 年)	○	○	【査定上のポイント】 ・先天性股関節脱臼は異なる評価となります。 ・同じ関節脱臼が 2 回以上ある場合は厳しい評価となります。 【告知のポイント】 部位(左右の別含む)・手術の有無
		既往症	治癒後:2 年未満	○	該当部位 (2 年)	○	○	
			治癒後:2 年以上	○	○	○	○	
	アキレス腱断裂	現症		○	×	○	○	【告知のポイント】 部位(左右の別)、治療内容(手術の有無含む)・後遺症の有無(有りの場合その詳細)
		既往症	手術後(かつ治癒後) :1 年未満	○	32 or 33 番 (1 年)	○	○	
			手術後(かつ治癒後) :1 年以上	○	○	○	○	

健康診断書・人間ドックにおける経過観察判定についての目安

- 注 1) 下表は、健康診断・人間ドックにおける判定結果が「経過観察」である場合の目安です。「再検査」や「精密検査」である場合は除きます。
- 注 2) 判定結果が「経過観察」であっても「1年未満の経過観察」である場合など、実質的に「再検査」判定と考えられるものは除きます。逆に、「1年後再検査」という判定については「経過観察」判定として取り扱います。
- 注 3) 症状がある場合や、告知内容、過去の検査所見の推移、および関連検査項目の所見などにより、個別判断となる場合があります。
- 注 4) 胆のうポリープ、腎結石など同一所見名で本文に別途記載があるものがあります。下表は、健康診断書・人間ドックにおける経過観察判定についての目安ですので、健康診断での指摘に限定していない本文の目安とは異なる場合があります。
- 注 5) 要再検査・要精密検査などの判定の場合、その内容や検査項目によりますが、原則として再検査・精密検査実施後にその結果の提出が必要になります。再検査・精密検査未実施の場合は、原則としてお引受できません。

検査名	所見名	目安			
		死亡	医療	ガン	特定疾病
胸部X線	・横隔膜の挙上 ・胸膜肥厚 ・硬化影 ・胸膜癒着 ・線状影 ・索状影 ・ブラ・ブレブ(肺のう胞) ・気腫性変化 ・石灰化(像) ・大動脈弓突出 ・大動脈の蛇行 ・脊柱側弯	○	○	○	○
	・肺気腫	条件付～×	条件付～×	○	×
	・結節影	○	条件付～×	○～×	○～×
心電図	・RSR'パターン ・不完全右脚ブロック ・完全右脚ブロック ・洞性不整脈 ・洞徐脈 ・洞調律 ・左軸偏位 ・右軸偏位 ・不定軸 ・1度房室ブロック ・境界域Q波 ・左室高電位 ・時計回転 ・反時計回転 ・心房調律 ・房室接合部調律 ・冠状静脈洞調律 ・R波高電位 ・低電位差	○	○	○	○
	・左脚前枝ブロック	○	条件付	○	○

検査名	所見名	目安			
		死亡	医療	ガン	特定疾病
腹部エコー	・肝のう胞 ・脂肪肝 ・胆のう壁肥厚 ・腎のう胞(のう胞腎は除く) ・副脾 ・肝内石灰化 ・腎石灰化 ・膵臓(尾部)描出／観察不良	○	○	○	○
	・膵のう胞 ・肝内結石 ・膵石 ・のう胞腎	×～条件付	×	×～○	×
	・胆のうポリープ(※) ・胆のう腺筋腫症 ・腎血管筋脂肪腫 (※)胆のうポリープについては、経過観察判定(1年以上の経過観察判定の場合のみ。1年後再検査を含む)と健診結果にて直接確認できる場合は○	○	条件付～×	×～○ (※)	×～○ (※)
	・胆のう結石 ・肝血管腫	○	条件付	○	○
	・腎結石	○～条件付	条件付	○	○～×
胃部X線	・粘膜の不整 ・巨大レリーフ ・胃びらん ・びらん性胃炎 ・胃潰瘍癒痕 ・十二指腸潰瘍癒痕 ・瀑状胃 ・胃下垂 ・食道裂孔ヘルニア	○	○	○	○
	・胃粘膜下腫瘍 ・食道粘膜下腫瘍 ・胃ポリープ(疑含む)(※) ・透亮像 ・隆起性病変 (※)胃ポリープについては、経過観察判定(1年以上の経過観察判定の場合のみ。1年後再検査を含む)と健診結果にて直接確認できる場合は○	条件付～× (※)	条件付～×	×～○ (※)	× (※)
	・胃憩室 ・食道憩室 ・十二指腸憩室	○	条件付	○	○